

ДГМУ 2022

ЛФ 1 курс

Первая помощь 1 семестр 14.04.22

#1

Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи?

Разрешено

Запрещено

Разрешено в случае крайней необходимости

Разрешено, если есть у пострадавшего в наличии

#2

При каких состояниях ребенка педагог может оказать ему первую помощь?

ожоги

травмы различных областей тела

инородные тела верхних дыхательных путей

отморожения

высокая температура

#3

При каких состояниях ребенка педагог может оказать ему первую помощь?

отсутствие сознания

отравление

наружные кровотечения

боли в животе

остановка дыхания и кровообращения

боли в груди

#4

Первая помощь оказывается во всех нижеперечисленных случаях, кроме следующего:

отсутствие сознания, дыхания и кровообращения

травмы различных областей тела и наружные кровотечения

инородные тела в верхних дыхательных путях

ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения

отморажение и другие эффекты воздействия низких температур

отравления

острые инфекционные заболевания

#5

Наблюдение за пострадавшим, которому оказана первая помощь, осуществляется:

до доставки пострадавшего в медицинскую организацию

до прибытия скорой медицинской помощи на место происшествия

до улучшения его самочувствия

до момента передачи его бригаде скорой медицинской помощи

#6

У мужчины 55 лет на фоне психоэмоционального стресса возникли сильные жгучие боли за грудиной. В чем будет заключаться первая помощь?

придать пострадавшему комфортное положение, обеспечить физический и эмоциональный покой, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия

уложить пострадавшего с приподнятыми нижними конечностями, дать таблетку нитроглицерина под язык, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия

предложить пострадавшему посетить поликлинику, рекомендовать принять таблетку нитроглицерина под язык, проводить пострадавшего до поликлиники

позвонить родственникам пострадавшего, выяснить, какие лекарства он принимает, дать ему принять эти лекарства, уложить, обеспечить физический и эмоциональный покой, при сохранении болей в течение часа вызвать скорую медицинскую помощь

придать пострадавшему комфортное положение, обеспечив физический и эмоциональный покой, вызвать скорую медицинскую помощь, наблюдать за пострадавшим до ее прибытия, предложить больному принять назначенные ему лекарства

#7

Укажите основную цель обзорного осмотра пострадавшего:

оценить его общее состояние

обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде всего, артериального)

попытаться обнаружить ранения различных областей тела

определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой помощи

#8

К мероприятиям первой помощи относится все нижеперечисленное, кроме следующего:

мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи, вызов скорой медицинской помощи

определение наличия сознания и признаков жизни у пострадавшего

мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации

мероприятия по применению обезболивающих средств при тяжелых травмах и шоке

мероприятия по осмотру пострадавшего, остановке наружного кровотечения и оказанию первой помощи при травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью пострадавшего

придание пострадавшему оптимального положения тела и контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение)

оказание психологической поддержки пострадавшему и передача его бригаде скорой медицинской помощи

#9

Выберите последовательность подробного осмотра пострадавшего, находящегося в сознании:

голова, шея, грудная клетка, живот, ноги и руки

грудная клетка, голова и шея, ноги и руки, живот

голова, грудная клетка, живот, шея, руки и ноги

ноги и руки, голова и шея, грудная клетка и живот

#10

После оказания первой помощи до прибытия бригады скорой медицинской помощи водителю необходимо, прежде всего, осуществлять следующие действия:

продолжать звонить диспетчеру скорой медицинской помощи для выяснения, когда прибует бригада, для определения необходимости в самостоятельной транспортировке пострадавших

продолжить контролировать состояние пострадавших и оказывать им психологическую поддержку

для скорейшего оказания медицинской помощи пострадавшим транспортировать их попутным или служебным автотранспортом навстречу бригаде скорой медицинской помощи

подготовить попутный или служебный автотранспорт к госпитализации пострадавших

#11

Для проверки дыхания у пострадавшего необходимо выполнить следующее действие:

поднести ко рту и носу пострадавшего зеркальце или металлический предмет, чтобы по его запотеванию определить наличие дыхания

поднести к носу и рту пострадавшего клочок ватки, нитку или перышко, чтобы по их колебаниям определить наличие дыхания

наклониться над ртом и носом пострадавшего и попытаться услышать дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движение грудной клетки у пострадавшего

положить руку на грудную клетку пострадавшего, пытаясь ощутить дыхательные движения пострадавшего

#12

При наличии признаков сознания у пострадавшего при оценке его состояния следует прежде всего:

произвести осмотр на наличие у него кровотечения и по возможности остановить его

опросить пострадавшего и выяснить обстоятельства травмы

дать понюхать ему нашатырный спирт для предупреждения потери сознания

попытаться успокоить пострадавшего, предложить ему воды

#13

Для оценки сознания пострадавшего следует выполнить следующие действия:

похлопать по щекам пострадавшего, надавить на болевые точки

потормошить за плечи, спросить, что с ним и нужна ли ему помощь

окликнуть пострадавшего громким голосом

поднести к носу пострадавшего ватку с нашатырным спиртом

#14

Какой метод используется для открытия дыхательных путей пострадавшему без сознания:

запрокидывание головы с приподнятием шеи

приподнятие головы с поддержкой шеи

нейтральное положение с фиксацией подбородка

запрокидывание головы с приподнятием подбородка

#15

Для сохранения проходимости дыхательных путей пострадавшего без сознания надо перевернуть:

в безопасное положение на спине, ноги приподнять на 30 см

на живот, подложив что-нибудь под голову

в устойчивое боковое положение на бок, лицом к себе

ни в коем случае не трогать пострадавшего!

#16

Подробный осмотр пострадавшего проводится в следующем порядке:

лицо, шея, грудь, спина, голова, живот, таз, конечности

грудь, спина, голова, шея, живот, таз, конечности

голова, шея, грудь, спина, живот, таз, конечности

голова, грудь, спина, живот, верхние конечности, нижние конечности

#17

Если при попытке оказать помощь пострадавшему его поведение угрожает вашей собственной безопасности, то вы должны:

постараться усмирить пострадавшего, чтобы предотвратить нанесение вам увечья

попытаться успокоить пострадавшего, взяв его за руку, и обратиться к нему тихим голосом

говорить с пострадавшим властно, чтобы он вам подчинился

отойти на безопасное расстояние от пострадавшего, по необходимости вызвать скорую медицинскую помощь и ждать ее прибытия

#18

Вы определили, что у пострадавшего отсутствует сознание. Когда необходимо вызвать скорую медицинскую помощь?

сразу

после проверки дыхания

после оказания необходимой первой помощи

не имеет большого значения

#19

Как часто следует пополнять аптечку первой помощи (автомобильную)?

1 раз в год

1 раз в 1,5 года

1 раз в 3–5 лет

по мере израсходования ее компонентов

#20

При наличии у пострадавшего признаков артериального кровотечения из области запястья предпочтительно:

выполнить прямое давление на рану, наложить давящую повязку

наложить кровоостанавливающий жгут ближе к ране

вложить бинт в локтевую ямку и выполнить максимальное сгибание конечности в суставе

согнуть конечность в локтевом суставе

#21

Первую помощь обязаны оказывать:

лица, с медицинским образованием

любые очевидцы происшествия

лица, прошедшие тренинги по первой помощи

сотрудники соответствующих служб, находящиеся при исполнении

#22

При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее:

причину травмы

наличие крупных ран

наличие дыхания

наличие сознания

проходимость дыхательных путей

#23

Проведение первичного осмотра, пострадавшего начинается с:

проверки наличия дыхания

проверки наличия пульса

призыва на помощь

проверки наличия сознания

#24

Если у пострадавшего отсутствует сознание, то следующее ваше действие будет:

проверка наличия дыхания

проверка наличия пульса

призыв на помощь

проверка наличия ран

#25

Алгоритм оказания первой помощи начинается с:

осмотра места происшествия

первичного осмотра пострадавшего

вызова специалистов

вторичного осмотра

#26

По российским законам может быть применено наказание в случае, если:

первая помощь оказана неправильно

вы только вызвали "Скорую помощь" и больше ничего не делали

вы оставили пострадавшего без помощи

вы позвали на помощь, но сами ничего не делали

#27

Если у пострадавшего нет сознания, но есть пульс и дыхание, то его надо:

повернуть на бок (там, где нет повреждений)

не трогать его

повернуть на спину (если нет повреждений)

привести в чувства любым способом

#28

К международным алгоритмам оказания первой помощи относят:

осмотр места происшествия

первичный осмотр

вызов скорой помощи

вторичный осмотр

оставления места происшествия

#29

Основная задача оказания первой помощи пострадавшему:

поддержание жизнедеятельности пострадавшего до приезда специалистов

диагностика причины травмы пострадавшего

оказание медицинской помощи пострадавшему в полном объеме

все выше сказанное

#30

Признаки жизни:

наличие сохраненного дыхания

наличие сохраненного дыхания, наличие сердечной деятельности

наличие сохраненного дыхания, наличие реакции зрачков на свет

наличие сохраненного дыхания, наличие сердечной деятельности, наличие реакции зрачков на свет

#31

Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи:

Для прекращения действия повреждающих факторов

Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего

Для поддержания жизни пострадавшего

Для предупреждения развития тяжелых осложнений

Для лечения острых заболеваний

#32

«Золотой час» — это:

Время с момента получения травмы до поступления в больницу

Время с начала оказания помощи до поступления в больницу

Время с момента транспортировки пострадавшего

Время с момента приезда скорой помощи

#33

«Золотой час» для пострадавшего, получившего травму, начинается:

С момента начала оказания помощи

С момента транспортировки пострадавшего

С момента получения травмы

С момента приезда скорой помощи

#34

Перечислите первоочередные мероприятия первой помощи

Обеспечение безопасного оказания помощи

Остановка наружного кровотечения

Обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей

Сердечно-легочная реанимация

транспортировка больного

#35

Укажите, с чего начинают оказание первой помощи

Обеспечение безопасного оказания помощи

Остановка наружного кровотечения

Обеспечение проходимости дыхательных путей

Проведение простейших противошоковых мероприятий

Сердечно-легочная реанимация

#36

Перечислите сведения, которые необходимо сообщить диспетчеру при вызове скорой медицинской помощи в случае ДТП

По возможности точный адрес места происшествия и ориентиры места ДТП

Характер происшествия (столкновение, переворачивание, наезд)

Количество пострадавших, зажатие пострадавших

Номер телефона, с которого был сделан вызов скорой медицинской помощи, Ф.И.О. звонившего

Характер повреждений

#37

Укажите порядок сообщения информации диспетчеру скорой медицинской помощи

Адрес места происшествия. Характер происшествия. Время происшествия. Наличие пострадавших

Наличие пострадавших. Характер происшествия. Время происшествия. Адрес места происшествия

Характер происшествия. Время происшествия. Наличие пострадавших. Адрес места происшествия

Характер происшествия. Время происшествия. Наличие пострадавших

#38

Какие сведения о пострадавших в ДТП необходимо сообщить в первую очередь диспетчеру скорой медицинской помощи

Количество пострадавших, в том числе детей

Зажатие пострадавших

Наличие беременных женщин

Наличие пожилых людей

#39

Первую помощь имеют право оказывать:

Прохожий

Водитель

Сотрудник ГИБДД

Спасатель

Никто, кроме врача

#40

Выберите верную последовательность мероприятий первой помощи в ДТП

Провести осмотр пострадавших; оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь; обеспечить собственную безопасность

Обеспечить собственную безопасность и безопасность пострадавших; вызвать скорую медицинскую помощь; провести осмотр пострадавших; оказать первую помощь

Оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь; обеспечить собственную безопасность

Оказать первую помощь, оценить состояние, обеспечить собственную безопасность

#41

При оказании первой помощи в первую очередь необходимо:

Немедленно оказать первую помощь пострадавшему

Обеспечить безопасность оказания помощи

Оказать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь

Позвонить в скорую помощь

#42

Пострадало два человека: у одного из пострадавших «признаки жизни» не определяются, у другого определяется наружное кровотечение. Какому из пострадавших необходимо оказать помощь в первую очередь?

Пострадавшему без «признаков жизни»

Пострадавшему с наружным кровотечением

Пострадавшему, кто находится ближе к спасателю

Пострадавшему, который позвал

#43

Укажите последовательность «спасательных вопросов»

Что? Где? Когда? Кто? Как?

Где? Что? Когда? Кто? Как?

Кто? Что? Где? Когда? Как?

Когда? Как? Что? Почему? Кто?

#44

Вы оказываете помощь пострадавшим. В салоне пострадавшего автомобиля находится три человека: Водитель — без сознания. У пассажира, рядом с водителем — открытая рана предплечья, сильного кровотечения из раны нет. На заднем сиденье — ребенок 6 лет, плачет. Видимых повреждений у ребенка нет. Кому из пассажиров вы окажите помощь в первую очередь?

Водителю

Пассажиру, сидящему на переднем сиденье

Ребенку

Вызвать скорую

#45

Тактические приемы оказания первой помощи пострадавшему с острой психической травмой (выраженным агрессивным поведением)

Обеспечение безопасности пострадавшего

Обеспечение безопасности окружающих

Обеспечение собственной безопасности

Вызов скорой помощи

#46

Стресс — это:

Состояние выраженного эмоционального напряжения, возникающее у человека в ответ на сильное внешнее воздействие, как приспособление организма к новым условиям

Состояние пострадавшего после тяжелой травмы, сопровождающееся нарушением сознания

Состояние выраженного эмоционального напряжения

Приспособительная реакция организма, после тяжелой травмы

#47

Избыточный стресс, возникающий у пострадавшего, может вызвать:

Острые психические реакции

Панику на месте происшествия

Сонливость

Посттравматические расстройства здоровья у пострадавших

#48

Острые психические реакции у пострадавших проявляются в виде следующих состояний:

Истерика

«Нервный озноб»

Ступор

Агрессивное поведение

Сонливость

#49

Укажите варианты агрессивного поведения пострадавших с острой психической травмой:

Гнев

Стремление к самоповреждению

«Нервный озноб»

Выраженное двигательное возбуждение

#50

Ступор проявляется у пострадавших с острой психической травмой как:

Сонливость

«Нервный озноб»

Безразличие к ситуации

Отсутствие сознания

#51

Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике

Оцепенение

«Театральное» поведение

Агрессивность

Плаксивость

#52

Истерика проявляется у пострадавших с острой психической травмой как:

Театральное поведение

«Нервный озноб»

Рыдания и крик

Выраженное двигательное возбуждение

#53

Выберите основное мероприятие первой психологической помощи для пострадавшего с истерикой

Неожиданно совершить отвлекающее действие, например, громко крикнуть

Лишить пострадавшего внимания окружающих

Заставить пострадавшего выполнить конкретное обучение

Говорить тихо, медленно и четко

#54

Выберите основное мероприятие первой психологической помощи для пострадавшего, находящегося в ступоре:

Неожиданно совершить отвлекающее действие, например, громко крикнуть

Лишить пострадавшего внимания окружающих

Заставить пострадавшего выполнить конкретное поручение

Говорить тихо, медленно и четко

#55

Выберите основное мероприятие первой психологической помощи для пострадавшего с агрессивным поведением

Неожиданно совершить отвлекающее действие, например, громко крикнуть

Лишить пострадавшего внимания окружающих

Заставить пострадавшего выполнить конкретное поручение

Говорить тихо, медленно и четко

#56

Пострадавших с острой психической травмой можно привлекать к оказанию помощи

Пострадавших с острой психической травмой ни в коем случае нельзя привлекать к оказанию помощи!

Пострадавших с острой психической травмой можно привлекать к оказанию помощи, давая простые поручения: «принеси, отнести, поддержи, передай, посмотри, встретить»

Пострадавший с острой психической травмой должен лежать неподвижно

Пострадавший с острой психической травмой должен оказывать первую помощь

#57

Перечислите, от чего зависит тяжесть острой психической травмы у пострадавшего

Состояние общего здоровья пострадавшего

Масштабность последствий происшествия

Темперамент пострадавшего

Тяжесть полученных физических травм

От оказанной первой помощи

#58

При оказании первой помощи пострадавшему ребенку, необходимо:

Установить с ребенком словесный и тактильный контакт

Дать мягкие игрушки, чтобы отвлечь от общего осмотра и манипуляций

По возможности привлечь родственников и знакомых к оказанию помощи

Обязательно изолировать ребенка от родителей или родственников

Привлечь к оказанию помощи самого пострадавшего ребенка

#59

Ребенку оказана первая помощь. Можно ли до приезда скорой медицинской помощи оставить ребенка одного

Нет, ни в коем случае

Ребенка можно оставить без присмотра, ведь первая помощь оказана

Можно, если ребенок спокоен

Можно если ребенок в сознании

#60

Оказывать психологическую поддержку пострадавшим могут:

Ребенок

Спасатель

Водитель

Психолог

Случайный прохожий

#61

При оказании первой помощи пострадавшим с острыми психическими расстройствами необходимо:

Успокоить и установить словесный контакт с пострадавшим

Дать теплое сладкое питье

Вызвать скорую медицинскую помощь

Дать обезболивающий препарат

#62

Перечислите приемы психологического воздействия на пострадавшего с острой психической травмой

Представиться пострадавшему

Объяснить свои действия по оказанию помощи

Установить и поддерживать с пострадавшим словесный контакт

Дать обезболивающий препарат

#63

Перечислите методы психологического воздействия на пострадавших с острой психической травмой

Вербальный

Невербальный

Тактильный

Визуальный

#64

Вербальный метод психологического воздействия заключается в следующем:

Установление и поддержание словесного контакта

Установление и поддержание визуального и тактильного контактов

Установление и поддержание визуального контакта

Установление и поддержание тактильного контактов

#65

Невербальный метод психологического воздействия на пострадавших заключается в следующем:

Установление и поддержание словесного контакта

Установление и поддержание визуального и тактильного контакта

Установление словесного контакта

Поддержание словесного контакта

#66

Укажите основную цель визуального контакта с пострадавшим:

Наблюдение за состоянием пострадавшего

Поддержание разговора с пострадавшим

Для оказания психологической помощи

Установление словесного контакта

#67

Перечислите признаки утомления:

Снижение скорости ответных реакции

Раздражительность, нарушение сна, головные боли

Снижение физической активности

Снижение умственной активности

Улучшение памяти

#68

При оказании первой помощи необходимо работать в перчатках

Да, в любом случае

Да, если пострадавший является асоциальным

Только при оказании первой помощи ВИЧ-инфицированным лицам

Только при оказании помощи молодым

#69

При оказании первой помощи на кожу спасающего случайно попала кровь пострадавшего.

Укажите верную последовательность мер профилактики инфекций, передающихся с кровью (ВИЧ-инфекция, гепатиты и др.)

Тщательно промыть загрязненные кровью участки кожи теплой водой с мылом

Двукратно вымыть с мылом под проточной водой загрязненные кровью участки кожи, затем обработать 70 % этиловым спиртом

В течение 30 секунд обработать загрязненные кровью участки кожи 70 % этиловым спиртом; двукратно вымыть с мылом под проточной водой; повторно обработать 70 % этиловым спиртом

промыть рану холодной водой

#70

Признаки жизни:

наличие пульса на артериях

наличие симптома «кошачьего глаза»

трупное окоченение

помутнение и высыхание роговицы глаз

наличие реакции зрачков на свет

#71

Признаки жизни:

помутнение и высыхание роговицы глаз

наличие симптома «кошачьего глаза»

трупное окоченение

наличие дыхания

наличие сердцебиения

#72

Явные признаки смерти:

помутнение и высыхание роговицы глаз

наличие симптома «кошачьего глаза»

наличие пульса на артериях

наличие дыхания

наличие сердцебиения

#73

Периоды терминального состояния:

преагония

биологическая смерть

возбуждение

клиническая смерть

агония

торможение

асфиксия

#74

Признаки агонии:

зрачки вяло реагируют на свет

артериальное давление низкое

артериальное давление не определяется

пульс определяется только на сонных артериях

кожа обычной окраски

#75

Признаки клинической смерти:

сознание сумеречное с периодами длительного отсутствия

сознание отсутствует

дыхание отсутствует

дыхание очень редкое в виде судорожных вдохов

пульс на сонной артерии не определяется

пульс определяется периодически только на сонных артериях

артериальное давление низкое

#76

Продолжительность периода клинической смерти составляет ... минут:

5

10

15

20

30

#77

Продолжительность предагонии составляет:

несколько минут

до 1 часа

до 12 часов

до суток

от нескольких часов до нескольких суток

#78

Показания для проведения реанимационного пособия:

внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке

утопление

онкологические заболевания

тяжелая сердечная недостаточность

трупное окоченение

поражение электрическим током

хроническая почечная недостаточность

#79

Противопоказания для проведения реанимационного пособия:

внезапная остановка сердца вследствие удара мячом по грудной клетке

утопление

онкологические заболевания

тяжелая сердечная недостаточность

трупное окоченение

поражение электрическим током

острый инфаркт миокарда

#80

Возможные осложнения искусственных вдохов:

открытый пневмоторакс

попадание воздуха в желудок

западение языка

разрыв легкого у ребенка

разрыв аорты

#81

Признаки успешного проведения закрытого массажа сердца:

сужение зрачков

появление зрачкового рефлекса

появление самостоятельного дыхания

появление пульса на сонной артерии во время массажа сердца

появление кашлевого рефлекса

#82

Продолжительность реанимации (если не удастся запустить работу сердца) составляет ... мин:

10

20

30

40

60

#83

Осложнения закрытого массажа сердца:

попадание воздуха в желудок

разрыв легкого

травма легких, сердца

перелом ребер

перелом позвоночника

#84

Особенности реанимации у детей первого года жизни:

нельзя разгибать голову при проведении искусственных вдохов

искусственные вдохи проводят методом «изо рта в нос»

компрессии проводят на нижнюю часть грудины кончиками двух пальцев

компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой

объем искусственного вдоха составляет 500–600 мл

#85

Особенности реанимации у детей первого года жизни:

при проведении искусственных вдохов запрокинуть голову

искусственные вдохи проводят одновременно и в рот, и в нос

компрессии проводят двумя руками

компрессии проводят на нижнюю часть грудины одной рукой

объем искусственного вдоха равен объему полости рта

#86

Комплекс реанимационных мероприятий необходимо проводить до появления у пострадавшего:

двигательной активности

ясного сознания

членораздельной речи

признаков оживления

аппетита

#87

О наступлении клинической смерти можно говорить при появлении у пострадавшего:

на теле темных пятен

закатывании глазных яблок

высыхании глазных яблок

отсутствии сухожильных рефлексов

остановки кровообращения

#88

Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает помощь один спасатель:

2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

2 вдоха искусственного дыхания после 30 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

1 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

#89

При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из желудка необходимо

повернуть пострадавшего на бок и надавить кулаками ниже пупка

приподнять ноги, надавить ладонями на грудину

не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до полного выхода воздуха

согнуть ноги в коленных суставах и надавить на область пупка

#90

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

отсутствие сознания

нет реакции зрачков на свет

нет пульса на сонной артерии

появление трупных пятен

деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

#91

Признаки биологической смерти (когда проведение реанимации бессмысленно)

отсутствие сознания

нет реакции зрачков на свет

нет пульса на сонной артерии

появление трупных пятен

деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

высыхание роговицы глаза (появление селедочного блеска)

#92

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии

15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

30 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

30 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

#93

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (в случае внезапной смерти):

первый спасатель проводит непрямой массаж сердца. Второй спасатель проводит искусственное дыхание и информирует партнеров о состоянии пострадавшего

первый спасатель информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Второй спасатель проводит искусственное дыхание. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего и готовится к смене первого спасателя

первый спасатель проводит искусственное дыхание. Второй спасатель проводит непрямой массаж сердца. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего

первый спасатель вызывает скорую помощь. Второй спасатель проводит непрямой массаж сердца и искусственное дыхание

#94

В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и дыхания у пострадавшего?

Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца)

Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких)

Проведение НМС (непрямого массажа сердца)

проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа сердца)

#95

Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при давлении руками на его грудину (выполнении непрямого массажа сердца)?

Основания ладоней обеих рук должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча

Основания ладоней обеих рук, которые накладываются одна на другую, должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону подбородка пострадавшего, а другой – в сторону живота

Давление руками на грудину выполняют основанием ладони только одной руки, расположенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Направление большого пальца не имеет значения

Давление руками на грудину выполняют, обхватив кулак одной руки ладонью другой. Направление пальцев не имеет значения

#96

Когда производится вызов скорой медицинской помощи:

непосредственно после оказания первой помощи пострадавшим
сразу после определения наличия пострадавших на месте происшествия
после определения примерного количества и состояния пострадавших
сразу же по прибытии на место дорожно-транспортного происшествия

#97

Частота надавливания при проведении компрессии грудной клетки составляет:

60–80 в 1 минуту

40–50 в 1 минуту

не менее 100 в 1 минуту

80–90 в 1 минуту

60 в 1 минуту

#98

При определении признаков жизни у пострадавшего проверяются:

признаки сознания

признаки сознания и дыхания

признаки сознания, дыхания и кровообращения

признаки сознания, дыхания и кровообращения, реакция зрачков на свет

#99

Правильная глубина вдоха искусственного дыхания при проведении сердечно- легочной реанимации контролируется по следующему признаку:

начало подъема грудной клетки

начало подъема живота

максимальное раздувание грудной клетки

появление сопротивления при выполнении вдоха

#100

В каких ситуациях следует приступить к сердечно-легочной реанимации?

при отсутствии у пострадавшего признаков сознания

при отсутствии у пострадавшего признаков сознания, дыхания и кровообращения

в случае, если с момента потери сознания прошло не более 5 минут

при наличии у пострадавшего признаков клинической смерти

#101

Что следует сделать в случае длительного выполнения реанимационных мероприятий и возникновении физической усталости у человека, оказывающего помощь?

прекратить проведение реанимационных мероприятий в случае, если с момента их начала прошло более 30 минут

привлечь помощника к осуществлению реанимационных мероприятий

уменьшить частоту надавливаний на грудину

снизить глубину надавливания на грудину

констатировать биологическую смерть пострадавшего, отметив это в соответствующей документации

#102

Качественные вдохи искусственного дыхания выполняются при соблюдении следующего условия:

максимально возможная скорость вдыхания

максимально возможный объем вдоха

качественное открытие дыхательных путей

качественная очистка полости рта

#103

При появлении признаков жизни у пострадавшего, которому проводилась сердечно-легочная реанимация, необходимо выполнить следующие действия:

придать пострадавшему устойчивое боковое положение и контролировать состояние пострадавшего

продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью

позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи
прекратить проведение сердечно-легочной реанимации

#104

Для открытия дыхательных путей пострадавшего необходимо:

запрокинуть голову, при этом следует положить одну руку на лоб, а другую подложить под шею пострадавшего

запрокинуть голову, положив при этом одну руку на лоб, а двумя пальцами подняв подбородок

очистить ротовую полость пальцами, обмотанными платком или бинтом

удалить зубные протезы и прочие инородные предметы из ротовой полости

расстегнуть стягивающую одежду, галстук, воротник

#105

Давление на грудину при проведении сердечно-легочной реанимации взрослому пострадавшему осуществляется следующим образом:

кулаком одной руки

ладонью одной руки

ладонями обеих рук, помещенными крест-накрест

двумя взятыми в замок руками, расположенными одна над другой с выпрямленными пальцами

#106

Сердечно-легочная реанимация в объеме искусственного дыхания и надавливаний на грудную клетку может не проводиться в следующих случаях:

при наличии у пострадавшего переломов нижней челюсти

при наличии у пострадавшего травм грудной клетки

при наличии у пострадавшего травмы, явно не совместимой с жизнью (например, отрыв головы)

при наличии у пострадавшего длительно существующего хронического, например, онкологического заболевания

при отсутствии возможности вызова скорой медицинской помощи

при отсутствии у человека, оказывающего первую помощь, аптечки или укладки

#107

Глубина надавливания при проведении компрессий грудной клетки при сердечно-легочной реанимации взрослому пострадавшему составляет:

4–5 см

5–6 см

3–4 см

2–3 см

#108

Сердечно-легочная реанимация выполняется до нижеперечисленных моментов, кроме:

прибытия скорой медицинской помощи

появления явных признаков жизни у пострадавшего

появления собственной усталости

истечения 30 минут с момента начала реанимации

#109

При отсутствии сознания у пострадавшего с признаками самостоятельного дыхания следует сделать следующее:

положить пострадавшему под голову валик из одежды, вызвать скорую медицинскую помощь

подложить валик из одежды под плечи пострадавшего, обеспечив сгибание шейного отдела позвоночника

придать пострадавшему устойчивое боковое положение

повернуть пострадавшего на живот

#110

Качественное искусственное дыхание методом «рот ко рту» может осуществляться при следующих условиях:

голова пострадавшего в нейтральном положении, нос зажат

голова пострадавшего запрокинута, ротовая полость очищена

голова пострадавшего запрокинута, нос зажат, ротовая полость очищена

голова может быть в любом положении, нос зажат

#111

Во время проведения сердечно-легочной реанимации у пострадавшего появились признаки жизни, в том числе и самостоятельное дыхание. Какое действие необходимо предпринять:

сообщить диспетчеру скорой медицинской помощи о том, что состояние пострадавшего улучшилось

прекратить проведение сердечно-легочной реанимации, продолжив наблюдение за пострадавшим

придать пострадавшему удобное для него положение

придать пострадавшему устойчивое боковое положение

#112

При проведении искусственного дыхания «рот-ко-рту» отмечается, что воздух не поступает в легкие, грудная клетка не поднимается. Какие действия следует предпринять в первую очередь:

попытаться очистить ротовую полость

выполнить искусственное дыхание методом «рот-к-носу»

извлечь изо рта пострадавшего вставные челюсти

увеличить силу и продолжительность вдувания

более тщательно запрокинуть голову

#113

При повторном осмотре пострадавшего, если у него есть сознания, то надо:

осмотреть и опросить пострадавшего

обработать раны при наличии

опросить свидетелей

контролировать состояние

оставить пострадавшего и уйти

#114

При повторном осмотре пострадавшего, если у него нет сознания, но есть дыхание и пульс, то надо:

придать оптимальное положение

обработать раны при наличии

опросить свидетелей и осмотр пострадавшего

контролировать состояние

приступить к СЛР

#115

Глубину, на которую должна прогибаться грудина при непрямом массаже сердца:

2-3 см

3-4 см

4-5 см

6-7 см

#116

Массаж сердца проводится:

на верхней части грудины

на грудной клетке с левой стороны

на границе средней и нижней трети грудины

на грудной клетке с правой стороны

#117

К первым признакам биологической смерти относят:

отсутствие сознания и пульса

отсутствие пульса и дыхания

симптом «кошачьего глаза»

нитевидный пульс и отсутствие дыхания

#118

Период собственно клинической смерти начинается с момента прекращения кровообращения и длится ...

4-5 минут

2-3 минуты

10-15 минут

до 1,5 часов

#119

К признакам клинической смерти относятся:

остановка дыхания и сердечной деятельности

отсутствие пульса на лучевой артерии

широкий зрачок, не реагирующий на свет

широкий зрачок, хорошо реагирующий на свет

#120

Признаки биологической смерти:

остановка дыхания и сердечной деятельности

зрачок не реагирует на свет

трупное окоченение, трупные пятна, «кошачий глаз»

резкое снижение (отсутствие) мышечного тонуса, трупные пятна, «кошачий глаз»

#121

Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной реанимации:

на спине на ровной непрогибающейся поверхности

на спине на кровати

оставить то, в котором он был обнаружен

роли не играет

#122

К признакам эффективности реанимационных мероприятий относятся:

появление пульсации на сонных артериях синхронно с закрытым массажем сердца

появление самостоятельной пульсации на сонных артериях

расширение зрачка с появлением реакции зрачка на свет

сужение зрачка с появлением реакции зрачка на свет

#123

Искусственное дыхание проводится в случаях:

когда дыхание отсутствует или нарушено в такой степени, что это угрожает жизни пострадавшего при утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, некоторых отравлениях, клинической смерти

когда дыхание отсутствует или нарушено в такой степени, что это угрожает жизни пострадавшего при утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, некоторых отравлениях, появлении первых признаков смерти

когда дыхание отсутствует или нарушено в такой степени, что это угрожает жизни пострадавшего при утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, некоторых отравлениях, трупных пятен

когда дыхание отсутствует или нарушено в такой степени, что это угрожает жизни пострадавшего при утоплении, удушении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, клинической смерти

когда дыхание отсутствует или нарушено в такой степени, что это угрожает жизни пострадавшего при утоплении, поражении электрическим током, тепловом и солнечном ударах, некоторых отравлениях, клинической смерти

#124

Признаки агонии:

затемненное сознание, отсутствием пульса, расстройством дыхания, которое становится неритмичным, поверхностным, судорожным, снижением артериального давления, холодная кожа, с бледным или синюшным оттенком

затемненное сознание, отсутствием пульса, расстройством дыхания

затемненное сознание, отсутствием пульса, расстройством дыхания, которое становится неритмичным, поверхностным, судорожным

затемненное сознание, отсутствием пульса, расстройством дыхания, которое становится неритмичным, поверхностным, судорожным, снижением артериального давления

затемненное сознание, отсутствием пульса, расстройством дыхания, которое становится судорожным, снижением артериального давления, холодная кожа, с бледным или синюшным оттенком

#125

«Тройной прием Сафара» для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей включает

голова отогнута кзади, нижняя челюсть выдвинута вперед, ротовая полость открыта

положение на спине, голова повернута на бок, нижняя челюсть выдвинута вперед

положение на спине, голова согнута кпереди, нижняя челюсть прижата к верхней

положение на спине, под лопатки подложен валик, нижняя челюсть прижата к верхней

#126

В основе внезапной коронарной смерти лежит

артериальная гипертензия

гипертрофия желудочков

фибрилляция желудочков

централизация кровообращения

#127

Достоверные признаки клинической смерти

отсутствие дыхания, отсутствие сердцебиения, отсутствие сознания, расширенные зрачки без реакции на свет

поверхностное и учащенное дыхание, узкие зрачки без реакции на свет, нитевидный пульс

судороги, холодные конечности, тахипноэ, гипотензия

фибрилляция желудочков, пульс малого наполнения, диспноэ, цианоз

#128

Достоверный признак остановки сердца

апноэ

отсутствие пульса на сонной артерии

отсутствие сознания

широкий зрачок без реакции на свет

#129

Закрытие вдоха в гортань корнем языка предупреждает

введение воздуховода

поворот головы на бок

прием Геймлиха

#130

Интенсивное наблюдение за пострадавшими в критическом состоянии включает

выполнение мероприятий гигиенического ухода

выявление проблем пациента

мониторинг жизненно важных функций

определение основных биохимических показателей крови

#131

Искусственное поддержание гемодинамики – это

второй этап

первый этап

приоритетный этап

третий этап

#132

К методам интенсивной терапии не относится

ИВЛ

СЛР

гемодиализ

парентеральное питание

#133

К терминальным состояниям относится

биологическая смерть

период агонии

постреанимационная болезнь

продромальный период

#134

Наличие у больного дыхания при проведении СЛР определяют

наклоном щекой к лицу больного

подсчетом дыхательных движений

приемом Геймлиха

спирометрией

#135

Непрямой массаж сердца проводится в положении

лежа на деревянном щите

лежа на спине на твердой поверхности

произвольном

с опущенной вниз головой

#136

Норма сатурации в процентах

80 – 85 %

85 – 90 %

90 – 92 %

96 – 99 %

#137

О смерти мозга свидетельствуют результаты

ЭКГ

спирометрии

фонокардиографии

электроэнцефалограммы

#138

Основной признак клинической смерти

отсутствие пульса

нарушение дыхания

патологическое дыхание

снижение температуры тела

#139

Основные мероприятия при выведении из клинической смерти

дать понюхать нашатырный спирт

проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

проведение непрямого массажа сердца и ИВЛ

разгибание головы

#140

Основные признаки клинической смерти

нитевидный пульс на сонной артерии

отсутствие пульса на лучевой артерии

отсутствие пульса на сонной артерии

расширение зрачков

#141

Первый этап реанимационных мероприятий

«тройной прием Сафара»

ИВЛ

непрямой массаж сердца

обеспечение проходимости дыхательных путей

#142

Показания для сердечно-легочной реанимации

агония и предагональное состояние

все внезапно развившиеся терминальные состояния

клиническая смерть

клиническая смерть и биологическая смерть

#143

При проведении непрямого массажа сердца компрессию на грудину взрослого человека производят

всей ладонью

одним пальцем

проксимальной частью ладони

тремя пальцами

#144

Признак биологической смерти

арефлексия

максимальное расширение зрачка

симптом «кошачьего зрачка»

фибрилляция желудочков

#145

Признак эффективности реанимационных мероприятий

зрачки широкие

отсутствие пульсовой волны на сонной артерии

отсутствие экскурсий грудной клетки

появление самостоятельного дыхания, сужение зрачков

#146

Признаки биологической смерти

наличие трупных пятен, помутнение роговицы

отсутствие пульса, дыхания, АД

отсутствие рефлексов роговицы

отсутствие сознания

#147

Продолжительность клинической смерти у взрослого человека в обычных условиях внешней среды

1 — 2 мин

10 — 15 мин

20 мин

3 — 5 мин

#148

Противопоказания для проведения сердечно-легочной реанимации

алкоголизм, психические заболевания

заведомо неизлечимые заболевания в последней стадии развития

старческий возраст

травмы, не совместимые с жизнью

#149

Расположение ладони при проведении непрямого массажа сердца

в 5-ом межреберном промежутке слева

на границе верхней и средней трети грудины

на нижней трети грудины

на середине грудины

#150

Реаниматология изучает вопрос:

диагностики клинической смерти

лечения хронических заболеваний

профилактики экстремальных состояний

функционирования основных жизненных систем

#151

Реанимация – это процесс

замещения функции дыхания

защиты пациента от операционной травмы

лечения терминальных состояний

оживления организма

#152

Смещаемость грудины к позвоночнику при непрямом массаже сердца у взрослого человека

1,5 — 2 см

2 — 4 см

5 см

7 — 8 см

#153

Состояние, при котором необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации

биологическая смерть

клиническая смерть

повреждения, не совместимые с жизнью

терминальная стадия

#154

Стадия терминального состояния, для которой характерны спутанность сознания, низкое АД или его отсутствие, бледность или цианоз, частое и поверхностное дыхание

агония

клиническая смерть

преагония

терминальная пауза

#155

Терминальное состояние расценивается как

глубокое нарушение жизненно важных функций

пограничное состояние между жизнью и смертью

пограничное состояние между нормой и патологией

состояние нарушенного сознания

#156

Тройной прием Сафара обеспечивает

адекватное кровообращение

адекватный уровень АД

проходимость дыхательных путей

устойчивое положение туловища

#157

Асфиксическое утопление характеризуется

попаданием воды в желудок

попаданием воды в дыхательные пути

рефлекторной остановкой сердца и дыхания

ларингоспазмом

механической асфиксией

#158

Биологическая смерть начинается с гибели

печени

клеток коры головного мозга

почек

клеток подкорковых структур головного мозга

сердца

#159

Боль при инфаркте миокарда купируется

антигипертензивными препаратами

спазмолитиками

сердечными гликозидами

наркотическими анальгетиками;

десенсибилизирующими препаратами

#160

Больному с гипертоническим кризом необходимо придать положение

стоя

лежа с опущенным головным концом

устойчивое боковое положение

лежа с приподнятым головным концом;

строго горизонтальное положение

#161

Больные, перенесшие анафилактический шок, нуждаются

в вызове участкового врача на дом

в наблюдении в течение 1 часа

в немедленной госпитализации

в санаторно-курортном лечении

в амбулаторном лечении

#162

В агональном состоянии реакция зрачка на свет

ослаблена

отсутствует

определяется только на яркий свет

не изменена

#163

В критических ситуациях пульс у новорождённого необходимо определять

на лучевой артерии

на плечевой артерии

на височной артерии

на сонной артерии

на бедренной артерии

#164

В основе отморожения лежит

расширение сосудов

спазм сосудов и угнетение обменных процессов в тканях

улучшение кровоснабжения тканей

усиление обменных процессов в тканях

гиповолемия

#165

В предагональном состоянии пульс определяется:

только на крупных сосудах

только на периферических сосудах

на крупных и периферических сосудах

пульс не определяется

все ответы верны

#166

В предагональном состоянии сознание

утрачено

сохранено

утрачено частично

сохранено частично

наблюдается ретроградная амнезия

#167

Вздутие эпигастральной области во время проведения ИВЛ свидетельствует

о правильности её выполнения

об эффективности её выполнения

о попадании воздуха в лёгкие

о попадании воздуха в желудок

бесполезности и безнадёжности ИВЛ

#168

Во время лыжной прогулки в морозный день у мужчины на щеке появилось белое пятно, в области которого нет чувствительности при прикосновении пальцев. В этом случае необходимо

растереть снегом место поражения

растереть щёку варежкой

согреть (приложить ладонь) пораженный участок

растереть спиртосодержащей жидкостью поражённый участок

приложить холодный компресс

#169

Возможное осложнение перелома рёбер

пневмония

пневмоторакс

асфиксия

гиперкапния

тампонада сердца

#170

Гемоторакс – это попадание в плевральную полость

воды

крови

экссудата

транссудата

воздуха

#171

Гипертонический криз – это состояние, характеризующееся

потерей сознания

резким понижением АД

резким повышением АД

непроизвольным мочеиспусканием

судорогами

#172

Голова пациента с носовым кровотечением при оказании неотложной помощи должна быть

повёрнута влево

опущена вниз, подбородок прижат к груди

повернута вправо

запрокинута назад

не имеет значения

#173

Для II степени электротравмы характерно

судорожное сокращение мышц без потери сознания

судорожное сокращение мышц с потерей сознания

судорожное сокращение мышц с потерей сознания и сердечными или легочными нарушениями

клиническая смерть

некроз тканей

#174

Для клинической смерти характерны все симптомы, кроме одного

отсутствие сердцебиения

сужение зрачков

цианоз или бледность кожных покровов

расширение зрачков

отсутствие дыхания

#175

Для оказания неотложной помощи при носовом кровотечении необходимо приготовить грелку

пузырь со льдом

раствор фурацилина

70% этиловый спирт

согревающий компресс

#176

Для отморожения III степени характерно

побледнение кожи с потерей чувствительности

кожа багрово-синяя, отёк, пузыри с прозрачной жидкостью

сильные боли, пузыри с темно-красной или бурой жидкостью

пузыри с черной жидкостью

небольшая припухлость, жжение

#177

Женщина 63-х лет жалуется на сильную головную боль, боль в сердце. Лицо пациентки одутловато, веки отёчны, АД 180/120 мм рт. ст. Определите неотложное состояние

приступ стенокардии

гипертонический криз

сердечная астма

инфаркт миокарда

отёк легких

#178

Женщина доставлена в травмпункт с закрытым переломом верхней трети большеберцовой кости и средней трети правого бедра. Сколько суставов необходимо фиксировать при иммобилизации?

три

два

четыре

один

в зависимости от наличия количества шин

#179

Кратковременная потеря сознания, связанная с уменьшением притока крови к головному мозгу называется

коллапсом

шоком

обмороком

гипертоническим кризом

эпилептическим приступом

#180

Критерий правильности выполнения непрямого массажа сердца

появление пульсовых волн на общей сонной артерии при проведении компрессий

появление самостоятельного пульса на общей сонной артерии

повышение артериального давления на периферических артериях

появление самостоятельного дыхания

по изменению цвета кожных покровов

#181

Критерий эффективности непрямого массажа сердца

появление пульсовых волн на общей сонной артерии при проведении компрессий

появление самостоятельного пульса на общей сонной артерии

повышение артериального давления на периферических артериях

появление самостоятельного дыхания

изменение цвета кожных покровов

#182

Максимальное время проведения СЛР

5 минут

30 минут

1 час

2 часа

45 минут

#183

Назовите один из дополнительных симптомов клинической смерти

отсутствие дыхания

отсутствие сознания

полное расслабление всей гладкой и поперечнополосатой мускулатуры;

отсутствие кровообращения

симптом «кошачьего глаза»

#184

Назовите один из основных симптомов клинической смерти

отсутствие дыхания

отсутствие артериального давления на периферических сосудах

симптом «кошачьего глаза»

трупные пятна

мертвенно бледная окраска кожи

#185

Ожоговая поверхность при химических ожогах промывается холодной проточной водой в течение

15-20 минут

5 минут

45 минут

60 минут

5-10 минут

#186

Раны по происхождению подразделяют на:

бытовые

случайные

операционные

производственные

сельскохозяйственные

#187

Признаки «свежей» раны:

потеря сознания

кровотечение

понижение температуры

повышение температуры

нарушение функции поврежденного участка тела

#188

Признаки «свежей» раны:

потеря сознания

«зияние» раны

боль

понижение температуры

повышение температуры

#189

Через рану в организм могут проникать возбудители:

газовой гангрены

ботулизма

столбняка

острой пневмонии

цистита

#190

Виды кровотечения:

наружное

закрытое

открытое

внутреннее

клапанное

#191

Виды кровотоков:

аортальное

артериальное

венозное

печеночное

геморрагическое

#192

Симптомы артериального кровотечения:

кровь ярко-алого цвета

кровь вишневого цвета

пульсирующий ток крови

ток крови не пульсирует

кровь вытекает в виде капель, как из губки

#193

Симптомы венозного кровотечения:

кровь ярко-алого цвета

кровь вишневого цвета

пульсирующий ток крови

ток крови не пульсирует

кровь вытекает в виде капель, как из губки

#194

Симптомы артериального кровотечения:

пульс ниже места кровотечения прощупывается

пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен

образующаяся подкожная гематома пульсирует

образующаяся подкожная гематома не пульсирует

кровь вытекает как из губки

#195

Симптомы венозного кровотечения:

пульс ниже места кровотечения прощупывается

пульс ниже места кровотечения не прощупывается или ослаблен

образующаяся подкожная гематома пульсирует

образующаяся подкожная гематома не пульсирует

кровь вытекает, как из губки

#196

Признаки капиллярного кровотечения:

возникает при повреждении поверхностных слоев кожи

кровь вишневого цвета

пульсирующий ток крови

ток крови не пульсирует

кровь вытекает в виде капель, как из губки

#197

Паренхиматозное кровотечение возникает при ранении:

желудка

кишечника

печени

селезенки

мочевого пузыря

#198

Способы остановки паренхиматозного кровотечения:

наложение жгута

наложение давящей повязки

прижатие к кости

максимальное сгибание конечности

только хирургическим путем

#199

Способы остановки венозного кровотечения:

наложение жгута

наложение давящей повязки

прижатие к кости

придать конечности возвышенное положение

только хирургическим путем

#200

Кровоостанавливающий жгут при артериальном кровотечении накладывают на:

кисть

предплечье

среднюю или верхнюю треть плеча

середину голени

среднюю треть бедра

#201

Признаки правильного наложения кровоостанавливающего жгута:

побледнение кожи конечности

конечность приобретает багрово-синюшную окраску

уменьшение кровотечения

прекращение кровотечения

пульс на артерии ниже места повреждения не определяется

пульс на артерии ниже места повреждения очень слабого наполнения

усиление кровотечения

#202

Максимальный срок наложения кровоостанавливающего жгута зимой составляет ... часов:

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

#203

Максимальный срок наложения кровоостанавливающего жгута летом составляет ... часов:

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

#204

Кровоостанавливающий жгут накладывают при ... кровотечении:

венозном

артериальном

капиллярном

паренхиматозном

внутреннем

#205

Для жгута-закрутки можно использовать:

галстук

бельевую веревку

шпагат

мягкий шарф

телефонный провод

#206

Колосовидная повязка накладывается на ... сустав:

локтевой

лучезапястный

тазобедренный

голеностопный

плечевой

#207

На волосистую часть головы накладывается ... повязка:

колосовидная

восьмиобразная

спиральная

круговая

«чепец»

#208

Правильно наложенная повязка:

хорошо закрывает поврежденную часть тела

вызывает побледнение кожных покровов

вызывает цианоз (синюшность) кожных покровов

не вызывает нарушения кровообращения

прочно удерживается на теле

легко сползает

вызывает отек тканей

#209

При ранении артерий кисти кровоостанавливающий жгут накладывают на:

область лучезапястного сустава

среднюю треть предплечья

верхнюю треть предплечья

локтевой сустав

нижнюю треть плеча

#210

Кровотечение, возникающее непосредственно после повреждения кро- веносных сосудов:

наружное

внутреннее

первичное

вторичное

смешанное

#211

Кровотечение, при котором кровь изливается в ткани, органы или полости организма человека:

наружное

внутреннее

первичное

вторичное

смешанное

#212

При ранении грудной клетки может возникнуть:

анафилактический шок

плевропульмональный шок

плевральный шок

перитонит

гемоторакс

#213

При ранении грудной клетки может возникнуть:

анафилактический шок

плевропульмональный шок

плевральный шок

пневмоторакс

перитонит

#214

При открытом и клапанном пневмотораксах накладывают ... повязку:

асептическую

давящую

герметизирующую

корсетную

косыночную

#215

Признаки проникающих ранений грудной клетки:

наличие раны грудной клетки

кровь в ране пузырится

прогрессирующее снижение артериального давления

мелкоточечные кровоизлияния в области грудной клетки и шеи

кровотечение из носа и ушей

#216

Достоверные признаки проникающего ранения органов брюшной полости:

холодный липкий пот

шум в ушах

резкое снижение артериального давления

выпячивание или выпадение из раны участка сальника или петли кишки

истечение из раны содержимого желудка, кишечника, мочи или желчи

#217

При ранении артерий кисти кровоостанавливающий жгут накладывают на:

область лучезапястного сустава

среднюю треть предплечья

верхнюю треть предплечья

локтевой сустав

верхнюю треть плеча

#218

Признаки острой кровопотери:

высокое артериальное давление, учащенное дыхание

высокое артериальное давление, частый пульс

низкое артериальное давление, частый нитевидный пульс

сонливость, бледность, редкий пульс

гиперемия кожных покровов, кома

#219

В случаях артериального кровотечения необходимо

прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут

освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить кровоостанавливающий жгут

жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин

жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час

#220

При проникающем ранении груди, следует:

прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить герметичную повязку

Извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку

Транспортировку производить только в положении «лежа»

транспортировку производить только в положении «сидя»

#221

При ранении конечностей необходимо:

промыть рану водой

обработать рану спиртовым раствором

накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем

промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем

#222

При проникающем ранении живота необходимо:

прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень

Вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень

По возможность дать обильно пить

транспортировка только в положении «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях ногах

транспортировка только в положении «сидя»

#223

Признаки артериального кровотечения

алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

над раной образуется валик из вытекающей крови

большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

очень темный цвет крови

кровь пассивно стекает из раны

#224

Признаки венозного кровотечения

алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

над раной образуется валик из вытекающей крови

очень темный цвет крови

кровь пассивно стекает из раны

#225

Когда следует накладывать давящие повязки

при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны

сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания

большое кровавое пятно на одежде

над раной образуется валик из вытекающей крови

#226

Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут

алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

над раной образуется валик из вытекающей крови

большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания

при укусах ядовитых змей и насекомых

#227

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении

не более чем на 0,5 часа

не более чем на 1 час

не более чем на 1,5 часа

не более чем на 2 часа

не более чем на 3 часа

#228

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет «Скорая помощь», контролировать пульс за медиальной лодыжкой

остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

#229

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки

прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

#230

В каком случае следует накладывать давящую повязку

при кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны

алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

большое кровавое пятно на одежде

в случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

#231

Признаки венозного кровотечения

кровь пассивно стекает из раны

над раной образуется валик из вытекающей крови

очень темный цвет крови

алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

#232

Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении?

Непосредственно на рану

Ниже раны на 4-6 см

Выше раны на 4-6 см

Туда где одна кость, максимально близко к ране

#233

При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным кровотечением, оказание первой помощи начинается:

С наложения импровизированной шины

С наложения жгута выше раны на месте перелома

С наложения давящей повязки

С максимального сгибания конечности в суставе

#234

Признаки артериального кровотечения

очень темный цвет крови

алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

над раной образуется валик из вытекающей крови

кровь пассивно стекает из раны

#235

В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?

Остановка кровотечения, наложение повязки

Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения

Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки

Обеззараживание раны, наложение повязки

#236

Что нужно делать при сильном кровотечении у ребенка в результате травмы до прибытия бригады скорой медицинской помощи?

если давящая повязка не помогает и кровотечение не останавливается, прижать артерию пальцем, наложить кровоостанавливающий жгут

промыть рану, обработать ее, затем наложить салфетку, туго забинтовать

наложить на рану салфетку, прижать, туго забинтовать

обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи

#237

Для временной остановки артериального кровотечения необходимо выполнить следующие действия:

осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить давящую повязку на рану, при необходимости наложить кровоостанавливающий жгут

наложить кровоостанавливающий жгут

наложить давящую повязку на рану, доставить пострадавшего в медицинскую организацию

зажать артерию в ране, наложить кровоостанавливающий жгут

#238

Выберите основные способы остановки кровотечения при ранении головы:

прямое давление на рану, наложение давящей повязки

наложение давящей повязки, пальцевое прижатие сонной артерии

пальцевое прижатие сонной артерии, наложение давящей повязки с использованием жгута

применение холода в области ранения, пальцевое прижатие сонной артерии

#239

При проникающем ранении груди самое важное – это:

попытаться остановить кровотечение давящей повязкой

не прикасаться к ране во избежание причинения вреда

наложить на рану груди повязку, не пропускающую воздух

своевременно обезболить пострадавшего

постоянно контролировать дыхание и кровообращение пострадавшего

придать пострадавшему устойчивое боковое положение

#240

Признаки кровопотери – это все, кроме следующего:

резкая общая слабость, чувство жажды

головокружение, мелькание мушек перед глазами

обморок, чаще при попытке встать, бледная, влажная и холодная кожа

урежение частоты сердечных сокращений, снижение частоты дыхания

учащенный слабый пульс, частое дыхание

#241

Если в ране находится инородный предмет, более правильным будет следующее:

срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение доступными способами, вызвать скорую медицинскую помощь

не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного предмета, предварительно зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую медицинскую помощь

не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников

обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь

аккуратно удалить инородный предмет, кровотечение из раны остановить путем заполнения ее стерильными салфетками, вызвать скорую медицинскую помощь, положить холод на место ранения

#242

Назовите наиболее быстрый способ остановки артериального кровотечения:

наложение кровоостанавливающего жгута

наложение давящей повязки

пальцевое прижатие артерии

прямое давление на рану

#243

Эффективность пальцевого прижатия артерии оценивается по следующим признакам:

визуально по уменьшению или остановке кровотечения

по правильности нахождения точки пальцевого прижатия

по отсутствию болевых ощущений у пострадавшего при давлении в точку прижатия

по сохранению пульса ниже места прижатия

#244

Пальцевое прижатие бедренной артерии выполняется:

в верхней трети бедра двумя большими пальцами рук, плотно обхватывающими бедро

выше места ранения на несколько сантиметров с усилием, достаточным для остановки кровотечения

в области выступа седалищной кости основанием ладони всем весом тела

в паховой области кулаком, зафиксированным второй рукой, весом тела участника оказания первой помощи

#245

Пострадавшему, находящемуся в сознании и имеющему признаки кровопотери, следует придать следующее положение:

устойчиво боковое положение

полусидячее положение

положение на спине с приподнятыми ногами

положение на спине с согнутыми и разведенными ногами

положение на животе

#246

Пальцевое прижатие подмышечной артерии производится:

в области плечевого сустава и надплечья к плечевой кости в подмышечной впадине прямыми, жестко зафиксированными пальцами в направлении плечевого сустава

давлением кулаком в область подмышечной впадины

большим пальцем к плечевой кости

сильным прижатием плеча к туловищу

#247

Для остановки венозного кровотечения используются все способы, кроме следующего:

прямое давление на рану

наложение давящей повязки на рану

наложение кровоостанавливающего жгута

максимальное сгибание конечности в суставе

#248

Пальцевое прижатие подключичной артерии производится:

к ключице с помощью четырех пальцев с усилием, достаточным для остановки кровотечения

в ямке под ключицей большим пальцем к первому ребру

указательным и средним пальцем в ямке над ключицей строго перпендикулярно поверхности грудной клетки

в ямке над ключицей к первому ребру с помощью четырех пальцев

#249

Пальцевое прижатие плечевой артерии осуществляется:

к плечевой кости с внутренней стороны плеча ниже бицепса с помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего сверху или снизу

большим пальцем под бицепсом пострадавшего с усилием, достаточным для остановки кровотечения

указательным и средним пальцем примерно посередине наружной поверхности плеча

к плечевой кости с наружной стороны плеча ниже бицепса с помощью четырех пальцев кисти, обхватывающей плечо пострадавшего сверху или снизу

пальцами обеих рук, обхватывая плечо в верхней части по окружности

#250

Признаком венозного кровотечения является:

струя крови темного (темно-вишневого) цвета разной интенсивности

кровь, вытекающая из раны по капле

алая пульсирующая струя крови

выделение темной крови со всей поверхности раны

#251

Для остановки кровотечения методом максимального сгибания необходимо:

наложить кровоостанавливающий жгут на область сустава, после чего согнуть конечность в суставе и зафиксировать в ручную или другим способом (бинтом, брючным ремнем и т. д.)

вложить в область сустава 1–2 бинта или свернутую валиком одежду, конечность согнуть и зафиксировать руками, жгутом, несколькими турами бинта или подручными средствами

наложить на рану давящую повязку, после чего согнуть конечность в суставе и зафиксировать

согнуть конечность в суставе, зафиксировать табельными или подручными средствами, для усиления эффекта вложить в область сустава твердый предмет (металлическую трубу, кусок дерева и т. д.)

#252

Какое положение должен принять пострадавший с носовым кровотечением:

сидя, голова запрокинута

лежа на боку, валик под головой

сидя, голову слегка наклонить вперед

лежа на спине, голова запрокинута

#253

Жгут можно ослаблять (снимать) не более чем:

на 10 минут

на 15–30 минут

на 15 минут

на 1–2 минуты

#254

При наличии у пострадавшего признаков артериального кровотечения необходимо выполнить следующее:

осуществить прямое давление на рану, при отсутствии эффекта – осуществить пальцевое прижатие артерии и наложить кровоостанавливающий жгут

выполнить наложение кровоостанавливающего жгута, на рану наложить давящую повязку

осуществить пальцевое прижатие артерии, наложить кровоостанавливающий жгут выше раны

осуществить прямое давление на рану, при отсутствии эффекта – осуществить пальцевое прижатие артерии и наложить кровоостанавливающий жгут, на рану наложить давящую повязку

#255

При подробном осмотре у пострадавшего обнаружена рана на голове с обильным кровотечением темной кровью, пострадавший в сознании. С чего следует начать оказывать первую помощь:

положить на рану марлевую салфетку из аптечки, аккуратно придавить

придать пострадавшему устойчивое боковое положение

приложить холод к голове

вызвать скорую медицинскую помощь

наложить на голову повязку типа «чепчик»

#256

Пострадавшему с ранением плеча и сильным венозным кровотечением была наложена давящая повязка на рану. Спустя 0–15 минут повязка пропиталась кровью. Что следует сделать:

удалить старую повязку, наложив на ее место новую

наложить новую повязку поверх старой

не трогая старую повязку, наложить кровоостанавливающий жгут

сняв старую повязку, плотно затампонировать рану салфетками марлевыми, после чего повторно наложить давящую повязку

#257

При оказании первой помощи пострадавшему в сознании с сильно кровоточащей раной в области голени необходимо:

вызвать скорую помощь, уложить на спину пострадавшего, обрызгать лицо холодной водой, согреть пострадавшего

вызвать скорую помощь, наложить жгут, поднять ноги и опустить головной конец пострадавшего, приложить холод к повязке

вызвать скорую помощь, поднести ватный шарик с нашатырным спиртом к носу пострадавшего, перенести пострадавшего на мягкое место, наложить давящую повязку

уложить пострадавшего на бок, наложить давящую повязку, приложить холод

#258

При наложении кровоостанавливающего жгута необходимо:

накладывать жгут на одежду или специальную ткань

освободить конечность от одежды

запомнить самому время наложения жгута

попросить пострадавшего запомнить время наложения жгута

#259

Признаками артериального кровотечения являются:

на раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови

кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной и непрерывной струей

кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей

кровь темно-вишневого цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей

#260

После наложения жгута пишется записка с целью:

указания место аварии и фамилии пострадавшего

указания время наложения жгута

указания повреждений, обнаруженных у пострадавшего

указание фамилии лица, наложившего жгут

#261

Признаками венозного кровотечения являются:

на раневой поверхности выступают мелкие, точечные капельки крови

кровь темно-вишневого цвета, вытекает медленно, равномерной непрерывной струей

кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей

кровь темно-вишневого цвета, выбрасывается сильной пульсирующей струей

#262

При оказании первой помощи пострадавшему с венозным кровотечением надо:

пережать сосуд пальцами выше места повреждения

наложить жгут выше места повреждения

наложить давящую повязку

наложить асептическую повязку

#263

Герметизирующую повязку накладывают при:

проникающем ранении грудной клетки

проникающем ранении живота
черепно-мозговой травме
при переломе конечностей

#264

Укажите основное мероприятие первой помощи при носовом кровотечении:

охладить пораженный участок тела
приложить холод, усадить, наклонить голову вперед и вниз
остановить кровотечение
наложить давящую повязку
доставить в теплое место
наложить шину

#265

Укажите основное мероприятие первой помощи при ранении:

охладить пораженный участок тела
приложить холод, усадить, наклонить голову вперед и вниз
остановить кровотечение
наложить давящую повязку
доставить в теплое место
наложить шину

#266

Укажите основное мероприятие первой помощи при ране головы с кровотечением:

охладить пораженный участок тела
приложить холод, усадить, наклонить голову вперед и вниз
остановить кровотечение
наложить давящую повязку
доставить в теплое место

наложить шину

#267

При промокании давящей повязки на конечности нужно:

снять предыдущую и наложить новую

ничего не делать

наложить давящую повязку не снимая предыдущую

наложить жгут

#268

На этапе первой помощи основная профилактическая мера по предупреждению дальнейшего инфицирования раны является:

смазывание краев раны жировым веществом

иссечение краев раны

наложение жгута выше раны

срочное ушивание раны

наложение повязки из чистой ткани

#269

Необходимо наблюдать пострадавшего с подозрением на внутреннее кровотечение, опасное для жизни, при ушибах частей тела:

живот

грудь

нога

лицо

#270

Кровотечение из раны конечности пульсирующей струей останавливают:

живот прижатием артерии по её ходу

наложением жгута

прикладыванием холода

поднятием конечности

наложением давящей повязки

#271

Какие изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран должны быть обязательно в аптечке?

стерильные салфетки, различные бинты, лейкопластырь и кровоостанавливающий жгут

бинты, лейкопластырь и кровоостанавливающий жгут

бинты различной ширины, вата и лейкопластырь

бинты, салфетки, жгут и вата

#272

Как поступить при обнаружении в ране мелких инородных предметов?

промыть рану водой, удалить пальцами инородные предметы, обработать рану настойкой йода

обернуть пальцы стерильной марлей и собрать мелкие инородные предметы

нельзя собирать мелкие инородные предметы с поверхности раны

обработать рану спиртовым раствором, затем удалить инородные тела

#273

Каким образом производится наложение кровоостанавливающего жгута на конечность?

жгут накладывается на 10-15 см ниже места повреждения, конечность фиксируется повязкой

жгут накладывается на 10-15 см выше места повреждения на подкладочный материал

жгут накладывается на 10-15 см выше места повреждения непосредственно на кожу

жгут накладывается на 10-15 см ниже места повреждения на подкладочный материал

#274

Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно?

кровотечение прекращается, конечность бледнеет, отсутствует пульсация

пульс не прощупывается, теряется чувствительность конечности

развивается отек, кожа приобретает багрово-синюшную окраску, появляются пузыри, наполненные жидкостью

кровотечение прекращается, пульс определяется

#275

С помощью какой повязки можно зафиксировать поврежденную верхнюю конечность согнутой к туловищу?

косыночной

працевидной

спиральной

колосовидной

#276

По анатомической классификации различают следующие виды кровотечений:

артериальные, венозные

капиллярные, паренхиматозные

легочные, желудочные

носовые

#277

При ранении вен шеи необходимо:

наложить тугую давящую повязку

применить пальцевое прижатие сосуда

наложить тугую давящую повязку с противоупором со здоровой стороны

затампонировать рану подручными средствами

#278

Укажите характеристику легочного кровотечения:

внезапное выделение темной крови полным ртом без позывов на рвоту

внезапное выделение алой, пенистой крови изо рта

внезапная рвота «кофейной гущей»

внезапное выделение алой крови с примесью «кофейной гущи»

#279

При оказании помощи больным с признаками легочного кровотечения больной должен находиться в положении ...

лежа вполоборота

сидя

в любом удобном для него

лежа на спине

#280

Укажите признаки кровотечения из пищевода и желудка:

тошнота, рвота «кофейной гущей»

выделение алой, пенистой крови изо рта

внезапная рвота полным ртом темной жидкой крови

отдельные плевки алой кровью

#281

При подозрении на перелом ребер тугие повязки на грудную клетку:

накладываются в случае окончательного перелома

накладываются в случае подозрения на перелом нескольких ребер

накладываются обязательно на время транспортировки в лечебное учреждение

не накладывают ни в каком случае

#282

Первая помощь при артериальном кровотечении:

наложение жгута производится на время не более 2-х часов поверх одежды или место его наложения оборачивается бинтом; в качестве жгута можно применять подручные материалы: резиновая трубка, поясной ремень, бинт, тонкая веревка и проволока

наложение жгута производится на время не более 2-х часов поверх одежды или место его наложения оборачивается бинтом; в качестве жгута можно применять подручные материалы: бинт, носовой платок, тонкая веревка и проволока

наложение жгута производится на время не более 2-х часов поверх одежды или место его наложения оборачивается бинтом; в качестве жгута можно применять подручные материалы: резиновая трубка, бинт

наложение жгута производится на время не более 2-х часов поверх одежды или место его наложения оборачивается бинтом; в качестве жгута можно применять подручные материалы: резиновая трубка, поясной ремень, бинт, носовой платок

наложение жгута производится на время не более 2-х часов поверх одежды; в качестве жгута можно применять подручные материалы: резиновая трубка, поясной ремень, бинт, носовой платок, тонкая веревка и проволока

#283

Виды повязок при повреждении черепа:

чепец, шапочка, на один глаз, на оба глаза, на ухо, восьмиобразная повязка на затылочную область и шею, на затылок, на теменную область

стерильные чепец, шапочка, на один глаз, на оба глаза, на ухо, восьмиобразная повязка на затылочную область и шею, на затылок, на теменную область, на подбородок

повязка сетчато-рубчатым бинтом, шапочка Гиппократ, на нос, на подбородок и нижнюю челюсть (уздечка), контурная повязка на щеку

бинтовые повязка сетчато-рубчатым бинтом, шапочка Гиппократ, на нос, на подбородок и нижнюю челюсть (уздечка), контурная повязка на щеку, на один глаз, на оба глаза, на ухо, на теменную область

#284

Первая помощь при проникающем ранении живота:

на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, выпавшие внутренности направить в брюшную полость, ничего давать пить, только смачивать водой ротовую полость

на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, выпавшие внутренности укрыть стерильными салфетками, ничего давать пить, только смачивать водой ротовую полость

на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, ничего давать пить, только смачивать водой ротовую полость

на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, выпавшие внутренности укрыть стерильными салфетками, ничего давать пить

на рану наложить стерильную повязку, выпавшие внутренности укрыть стерильными салфетками, ничего давать пить, только смачивать водой ротовую полость

#285

Признаки проникающего ранения грудной клетки:

затрудненное дыхание, кровотечение из открытой раны

затрудненное дыхание, кровотечение из открытой раны, всасывающий звук, исходящий из раны при каждом вдохе, кровохаркание

затрудненное дыхание, кровотечение из открытой раны, всасывающий звук, исходящий из раны при каждом вдохе, кровохаркание

затрудненное дыхание, кровотечение из открытой раны, всасывающий звук, исходящий из раны при каждом вдохе, сильная боль в области раны, кровохаркание

затрудненное дыхание, кровотечение из открытой раны, всасывающий звук, исходящий из раны при каждом вдохе, сильная боль в области раны, кровотечение

#286

Укажите последовательность мероприятий первой помощи пострадавшему проникающим ранением живота. В ране находится нож

Вызвать скорую медицинскую помощь; зафиксировать инородное тело и наложить повязку на рану; придать транспортное положение

Аккуратно достать инородное тело; наложить повязку; придать транспортное положение; вызвать скорую медицинскую помощь

Вызвать скорую медицинскую помощь, аккуратно достать инородное тело; наложить повязку; придать транспортное положение

наложить повязку; придать транспортное положение

#287

Укажите места наложения працевидной повязки

Область лба

Область носа

Область локтя

Область подбородка

Область пятки

#288

При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в первую очередь:

Обработать край раны йодом

Провести иммобилизацию конечности

Промыть рану перекисью водорода

Остановить кровотечение

#289

В каких случаях необходимо соблюдать меры профилактики заражения инфекциями, передающимися с кровью (ВИЧ-инфекция, гепатиты и др.)

Только при оказании первой помощи ВИЧ-инфицированным лицам

При оказании помощи любому пострадавшему

Только при оказании помощи асоциальным лицам

При оказании помощи молодым

#290

Укажите препараты, которые можно применить для обработки кожных покровов, загрязненных кровью

этиловый спирт

раствор бриллиантового зеленого

спиртовой раствор йода

Раствор хлоргексидина

#291

При случайном попадании крови пострадавшего на слизистую оболочку полости рта спасающего необходимо:

Прополоскать рот водой

Обработать 5 % спиртовым раствором йода

Прополоскать рот 70 % раствором этилового спирта

Прополоскать рот раствором хлоргексидина

#292

Положение, придаваемое пострадавшему с ранением грудной клетки:

горизонтальное

горизонтальное, голова повернута в сторону

полусидячее

лёжа на боку

#293

Транспортировка пострадавших при лёгочном кровотечении:

горизонтальное

горизонтальное, голова фиксирована и повернута в сторону

полусидячее

лёжа на боку

#294

Транспортировка пострадавших при желудочно-кишечном кровотечении:

горизонтальное

лёжа на щите

полусидячее

сидя

#295

При ранениях груди больного переносят:

лежа на спине с выпрямленными ногами

лежа на спине с приподнятыми и согнутыми в коленях ногами

лежа на животе

сидя или в полусидячем положении

лежа на спине на твердой поверхности

#296

Оказание первой помощи при вывихе включает:

прием обезболивающего

прием снотворного

вправление вывиха

холод на сустав

тепло на сустав

#297

Оказание первой помощи при вывихе включает:

прием снотворного

вправление вывиха

тепло на сустав

иммобилизацию сустава

доставку в больницу

#298

Симптомы вывиха:

вынужденное необычное положение конечности

укорочение конечности

удлинение конечности

невозможность производить движения в суставе

крепитация

#299

Абсолютные признаки перелома кости:

деформация кости

выпячивание под кожей костных отломков

локальная боль

нарушение функции поврежденной конечности

отек

#300

Абсолютные признаки перелома кости:

отек

нарушение функции поврежденной конечности

локальная боль

укорочение конечности

патологическая подвижность в месте перелома

крепитация

удлинение конечности

#301

Относительные признаки перелома кости:

деформация кости

выпячивание под кожей костных отломков

локальная боль

крепитация в месте перелома

отек

#302

Цели транспортной иммобилизации:

остановка кровотечения

профилактика усиления боли

уменьшение боли

профилактика новых переломов этой кости

профилактика превращения закрытого перелома в открытый

#303

Признаки закрытого перелома позвоночника:

резкая боль в месте повреждения, усиливающаяся при надавливании на голову или остистый отросток в месте перелома

отек места перелома

рефлекторное напряжение мышц спины

крепитация отломков костей

вынужденное необычное положение конечности

#304

Виды пневмоторакса:

наружный

закрытый

открытый

внутренний

клапанный

прямой

непрямой

#305

При переломе ребра на грудную клетку накладывают ... повязку:

асептическую

давящую

герметизирующую

циркулярную

косыночную

#306

Признаки закрытого перелома ребер:

кровотечение

крепитация

отставание при дыхании поврежденной половины грудной клетки

мелкоточечные кровоизлияния на коже

тахикардия

#307

Признаки закрытого перелома ребер:

локальная боль, усиливающаяся при вдохе, кашле, наклоне туловища

крепитация

кровотечение

мелкоточечные кровоизлияния на коже

учащенное сердцебиение

#308

Признаки тяжелого сотрясения головного мозга:

рвота

ретроградная амнезия

головная боль

потеря сознания более суток

кратковременная потеря сознания

нарушение функций мозга

одышка

#309

Оказание первой доврачебной помощи при сотрясении головного мозга:

транспортировка лежа на спине, голову повернуть на бок

тепло на голову

холод на голову

транспортировка лежа на спине, голову запрокинуть

транспортировка в полусидячем положении

#310

Признаки сдавливания головного мозга:

длительная потеря сознания, кома

временная потеря сознания

зрачки расширены

разная величина зрачков

зрачки сужены

#311

При тупой тяжелой травме живота запрещается:

холод на живот

тепло на живот

давать обезболивающее в виде таблеток

смачивать губы

полоскать рот водой

#312

При тупой тяжелой травме живота запрещается:

холод на живот

тепло на живот

смачивать губы водой

поить

полоскать рот водой

#313

Признаки перелома костей таза:

«симптом пятки» – невозможность оторвать пятку от земли в положении лежа

судороги

тошнота, рвота

боль

головная боль

#314

Симптомы травматического шока стадии возбуждения:

заторможенность

возбуждение

артериальное давление повышено

артериальное давление снижено

маскообразное выражение лица

#315

Симптомы травматического шока стадии торможения:

заторможенность

возбуждение

артериальное давление повышено

артериальное давление снижено

пульс напряжен

#316

Первая помощь при травматическом шоке:

прием обезболивающего

прием снотворного

прием возбуждающих средств (кофеин)

остановка кровотечения

транспортная иммобилизация при переломе

обильное питье с добавлением питьевой соды

искусственная вентиляция легких

#317

Первая помощь при травматическом токсикозе:

наложить согревающий компресс

наложить жгут выше места сдавления

обильное питье с добавлением питьевой соды

дать снотворное

дать возбуждающие препараты

#318

Симптомы травматического токсикоза:

кожа бледная

мелкие кровоизлияния и пузыри, наполненные светлой или кровянистой жидкостью

артериальное давление повышено

уменьшение выделяемой мочи (олигурия) вплоть до полного ее отсутствия (анурия)

брадикардия

#319

Комбинированными травмами, полученными в транспортной аварии, являются:

ушиб головного мозга и химический ожог кожи рук

повреждения легких и кишечника

черепно-мозговая травма и повреждение тазовых костей

перелом голени в сочетании с термическим ожогом

множественные переломы костей верхних конечностей

#320

Сочетанными травмами, полученными в транспортной аварии, являются:

ушиб головного мозга и химический ожог кожи рук

повреждения легких и кишечника

черепно-мозговая травма и повреждение тазовых костей

перелом голени в сочетании с термическим ожогом

множественные переломы костей верхних конечностей

#321

Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей:

смазать обожженную поверхность маслом или жиром

промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой

подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин

обработать обожженную поверхность спиртом и накрыть чистой салфеткой

#322

Правила обработки ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей

промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой

промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

промыть рану водой, обработать перекисью водорода

#323

При ранениях глаз или век

накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой

разрешается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век

все операции проводить в положении пострадавшего «сидя»

все операции проводить в положении пострадавшего «лежа»

запрещается промывать водой колотые и резаные раны глаз и век

#324

Первая помощь при ожогах глаз или век в случаях попадания едких химических веществ

раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи

раздвинуть осторожно веки пальцами, нейтрализовать жидкость (уксус или сода) и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от носа наружу

раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу

раздвинуть осторожно веки пальцами и промыть теплой водой. Промыть глаз струей холодной воды так, чтобы она стекала от изнутри к носу

#325

Действия при переохлаждении

предложить теплое сладкое питье

дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном опьянении, и доставить в теплое помещение

снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С

давать повторные дозы алкоголя недопустимо

после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду

#326

Действия при обморожении

как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение

снять одежду и обувь

укрыть одеялом или теплой одеждой

поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками

наложить масло и растереть кожу

#327

Действия в случае длительного сдавливания конечностей

обложить конечности холодом

после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности

согреть придавленные конечности

не давать жидкости до прибытия врачей

#328

Когда необходимо накладывать шины на конечности

видны костные обломки

при жалобах на боль

при деформациях и отеках конечностей

после освобождения придавленных конечностей

при укусах ядовитых змей

при подозрении на повреждение позвоночника

в случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей

#329

Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с подложенным под колени валиком или на вакуум-носилках в позе «лягушки»

при подозрении на перелом костей таза

при подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение тазобедренного сустава

при подозрении на повреждение позвоночника

при ранениях шеи

при проникающих ранениях живота

#330

Когда пострадавших переносят только на животе

в состоянии комы

при частой рвоте

в случаях ожога спины и ягодиц

при подозрении на повреждение спинного мозга. Когда в наличии есть только брезентовые носилки

при проникающих ранениях брюшной полости

при проникающих ранениях грудной клетки

#331

Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя

при проникающих ранениях грудной клетки

при ранениях шеи

при проникающих ранениях брюшной полости

при частой рвоте

#332

Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами

при проникающих ранениях брюшной полости

при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение

при проникающих ранениях грудной клетки

в состоянии комы

#333

Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей (появляются спустя 15 минут)

после освобождения сдавленной конечности- резкое ухудшение состояния пострадавшего

появление отека конечности с исчезновением рельефа мышц

отсутствие пульса у лодыжек

появление розовой или красной мочи

отсутствие пульса на сонной артерии

синюшный цвет кожи

#334

Признаки открытого перелома костей конечностей

видны костные обломки

деформация и отек конечности

наличие раны, часто с кровотечением

синюшный цвет кожи

сильная боль при движении

#335

Признаки закрытого перелома костей конечности

видны костные обломки

деформация и отек конечности

наличие раны, часто с кровотечением

синюшный цвет кожи

сильная боль при движении

#336

Признаки обморожения нижних конечностей

потеря чувствительности

кожа бледная, твердая и холодная на ощупь

нет пульса у лодыжек

при постукивании пальцем — деревянный звук

озноб и дрожь

снижение температуры тела

#337

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи

Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

#338

При переохлаждении пострадавшего находящегося в помещении необходимо поместить в ванну с температурой воды в пределах:

25 — 30 град

25 — 35 град

30 — 35 град

35 — 40 град

35 — 45 град

#339

При обморожении пострадавшему, находящемуся в помещении с укрытыми конечностями необходимая дальнейшая схема действия помощи:

дать 1-2 таблетки анальгина, дать обильное тёплое питьё, вызвать «Скорую помощь»

дать 1-2 таблетки анальгина, дать обильное тёплое питьё, предложить малые дозы алкоголя, вызвать «Скорую помощь»

дать обильное тёплое питьё, вызвать «Скорую помощь»

дать обильное тёплое питьё, дать 1-2 таблетки анальгина, вызвать «Скорую помощь»

дать обильное тёплое питьё, предложить малые дозы алкоголя, вызвать «Скорую помощь»

#340

В каком случае пострадавшего необходимо переносить на спине с приподнятыми или согнутыми в коленях ногами

в состоянии комы

при частой рвоте

при проникающих ранениях брюшной полости

при проникающих ранениях грудной клетки

при ранении шеи

#341

Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют подручные средства для их изготовления?

Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу.

Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают

Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань

Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу.

Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань

сгибают в коленных суставах и прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань

#342

О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом оказать?

У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу

У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки

У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод

У пострадавшего могут переломы шейки бедра, может быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки

#343

В какой последовательности следует осматривать ребенка при его травмировании?

конечности, область таза и живот, грудная клетка, шея, голова

голова, шея, грудная клетка, живот и область таза, конечности

грудная клетка, живот и область таза, голова, шея, конечности

конечности, голова, шея, область таза, живот, грудная клетка

#344

В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при повреждении позвоночника?

Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги

Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела

Уложить пострадавшего на бок

Уложить пострадавшего на живот

#345

Перелом это

трещины, сколы, раздробление костей

разрушение мягких тканей костей

трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела

трещины с разрушением окружающих мягких тканей

#346

Действия по помощи пострадавшему при попадании инородного тела в дыхательные пути:

Положить пострадавшего на бок и вызвать интенсивную рвоту

Нагнуть туловище пострадавшего вперед, нанести несколько интенсивных ударов ладонью между лопаток, при отсутствии эффекта — обхватить пострадавшего сзади, надавить 4-5 раз на верхнюю часть живота

Нанести пострадавшему, стоящему прямо, несколько интенсивных ударов ладонью между лопаток

положить пострадавшего на спину, нанести несколько интенсивных ударов кулаком в область грудины

#347

Первая медицинская помощь при вывихе конечности?

Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей водой, организовать транспортировку в больницу или травмпункт

Осуществить иммобилизацию конечности, дать доступные обезболивающие средства, приложить к поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать транспортировку в больницу или травмпункт

Дать обезболивающее средство, вправить вывих и зафиксировать конечность

Дать обезболивающее средство, организовать транспортировку в больницу или травмпункт

#348

Основные правила оказания первой помощи при травматическом шоке:

Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Восстановление нарушенного дыхания и сердечной деятельности, временная остановка кровотечения, борьба с болью, закрытие ран стерильными (чистыми) повязками, придание пострадавшему наиболее удобного положения, обеспечить приток свежего воздуха, организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи

Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять одежду или ослабить ее давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб холодный компресс. Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи

Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить теплые примочки на лоб и затылок

уложить пострадавшего на спину, поднять ножной конец. Дать понюхать нашатырный спирт, дать обезболивающее

#349

При переломах костей конечностей накладывается шина:

ниже области перелома

выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух ближайших суставов

выше области перелома

при переломах конечностей шина не накладывается

#350

При черепно-мозговой травме:

необходимо положить на голову тепло

необходимо положить на голову холод

необходимо наложить на голову марлевую повязку

необходимо наложить на голову тугую повязку

#351

Пострадавшему с травмой груди следует придать следующее положение:

положение на спине с приподнятыми ногами

устойчивое боковое положение

полусидячее положение с наклоном в пораженную сторону

положение на спине с полусогнутыми и разведенными ногами

положение на животе

#352

Укажите, в каких случаях осуществляется экстренное извлечение пострадавшего из аварийного автомобиля:

во всех случаях, когда пострадавшему требуется немедленное оказание первой помощи экстренное извлечение пострадавшего производится только силами сотрудников скорой медицинской помощи или спасателями МЧС

наличие угрозы для жизни и здоровья пострадавшего и невозможность оказания первой помощи в автомобиле

в случае, если у пострадавшего отсутствуют признаки серьезных травм

#353

Целью придания пострадавшему оптимального положения его тела является:

повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь

обеспечение доступа для наложения повязок, кровоостанавливающих жгутов и т. д.

придание пострадавшему удобного положения, обеспечивающего ему комфорт, уменьшающего степень его страданий и не усугубляющего нарушения жизненно важных функций

предупреждение или снижение риска самопроизвольного перемещения тела пострадавшего

#354

Какую помощь следует оказать пострадавшему с предположительным переломом костей голени в случае, если травма получена в населенном пункте:

зафиксировать голень подручными средствами, вызвать скорую медицинскую помощь

помочь пострадавшему принять удобное положение, вызвать скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту предполагаемого перелома

зафиксировать голень транспортными шинами, приложить холод, доставить пострадавшего в травмпункт

зафиксировать голень транспортными шинами, дать обезболивающее средство, вызвать скорую медицинскую помощь, приложить холод к месту предполагаемого перелома

#355

Придание устойчивого бокового положения пострадавшему следует начать:

с расположения одной руки пострадавшего под углом к его телу

с поворота нижней части его тела на бок

с расположения руки пострадавшего тыльной стороной ладони к его щеке

с расстегивания стягивающей одежды

#356

Выбор способа переноски пострадавшего при оказании первой помощи зависит:

от наличия средств переноски (носилок, строп) пострадавших

от предполагаемой дальности переноски

от желания пострадавшего

от количества участников оказания первой помощи, их физических возможностей и характера травм

#357

Переноску в одиночку на плече желательно не применять в отношении пострадавших с нижеприведенными травмами и состояниями:

травмы конечностей

травма головы

травмы груди и живота

ожоги и отморожения

отравления

#358

Переноску в одиночку волоком не рекомендуется применять для пострадавших со следующими травмами:

травмы грудной клетки

травмы живота

травмы головы

травмы нижних конечностей

#359

Какое положение лучше занять пострадавшему с травмой груди?

лежа, с приподнятыми ногами

полусидя

стоя у опоры

лежа на левом боку

#360

Транспортировать пострадавшего самостоятельно необходимо:

всегда, если он сам не может передвигаться

если у пострадавшего угрожающее жизни состояние

если нет возможности вызвать скорую медицинскую помощь

во всех перечисленных случаях

#361

После того как вы произвели наложение кровоостанавливающего жгута, травмированную конечность необходимо:

укутать

обездвижить и укутать

приподнять, обездвижить и укутать

обездвижить

#362

Какое положение необходимо придать пострадавшему с подозрением на травму живота:

полусидячее с наклоном в поврежденную сторону

лежа на спине с согнутыми в коленях и разведенными ногами

лежа на менее травмированном боку

лежа на боку с поджатыми ногами

#363

Какое положение необходимо придать пострадавшему с подозрением на травму грудной клетки?

полусидячее с наклоном в поврежденную сторону

лежа на спине с приподнятыми ногами

лежа на менее травмированном боку

лежа на боку с приведенными к туловищу ногами

#364

При иммобилизации нижней конечности, перед тем как накладывать шину, необходимо:

вернуть конечность в естественное положение

снять обувь

обувь не снимать, конечность без необходимости не трогать, не пытаться вернуть в нормальное положение

вернуть конечность в нормальное положение, снять обувь

#365

Ногy пострадавшего придавило обрушившейся конструкцией. Что вы сделаете, прежде чем извлечь его из-под завала?

будучи уверенным в отсутствии опасности, постараетесь самостоятельно извлечь пострадавшего
вызовете экстренные службы, позовете на помощь и, убедившись в отсутствии опасности, постараетесь извлечь пострадавшего

вызовете экстренные службы, позовете на помощь, затем, убедившись в отсутствии опасности, наложите жгут на конечность и попытаетесь самостоятельно извлечь пострадавшего

вызовете экстренные службы и будете ожидать их прибытия

#366

Первая помощь пострадавшему с травмой живота, сопровождающейся выпадением внутренних органов, заключается в следующем:

пытаться вправить выпавшие органы

оставлять выпавшие органы снаружи

накрывать выпавшие органы влажной, чистой тканью

приложить холод к выпавшим органам

#367

Перемещение пострадавшего с подозрением на травму позвоночника следует выполнять следующим способом:

на руках с привлечением нескольких человек

на твердой ровной поверхности (щит)

любым из перечисленных способов

ни одним из перечисленных способов

#368

Пострадавший в ДТП человек получил следующие повреждения: ссадины на лице, многочисленные кровоподтеки по всему телу. В области бедра одежда разорвана, имеется кровотечение обильной струей темно-вишневого цвета. Он находится на проезжей части. Что является приоритетным действием в этой ситуации:

обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи (перемещение пострадавшего, выставление знаков аварийной остановки и т. п.)

остановка кровотечения путем прямого давления на рану и наложение давящей повязки

обработка ссадин антисептическим раствором

вызов скорой медицинской помощи

придание пострадавшему оптимального положения тела

#369

Автомобиль, попавший в ДТП, несколько раз перевернулся. В результате пострадал водитель автомобиля. Есть необходимость в его экстренном извлечении вследствие риска возгорания автомобиля. О чем следует помнить в первую очередь:

извлекать пострадавшего необходимо очень бережно

при извлечении необходимо обязательно фиксировать голову и шею

извлечение следует выполнить как можно быстрее для снижения риска дополнительного повреждения пострадавшего пламенем

пострадавшего не следует извлекать, постараться устранить опасность возгорания своими силами

#370

Можно ли вправить вывих пострадавшему при оказании первой помощи:

можно, если пострадавший не ощущает боль

можно, если отек еще не наступил

можно, если об этом попросил пострадавший

нельзя, ни при каких обстоятельствах

#371

В качестве шины для иммобилизации конечности целесообразно использовать следующие предметы:

доски, палки, зонт

бинт, платок, простыня

трава, вода, мазь

ремень, пояс, галстук

#372

Транспортировка пострадавших сидя осуществляется при:

повреждении верхних конечностей и органов брюшной полости

переломе ключицы, перелом ребер

повреждении органов брюшной полости

повреждение костей черепа и лица

#373

Транспортировку пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо осуществлять:

лежа на боку

лежа на спине

сидя

стоя

#374

При ушибе в рамках оказания первой помощи надо:

наложить холодный компресс, обеспечить ушибленному органу покой

наложить согревающий компресс

осторожно растереть травмированный участок, наложить повязку

наложить жгут, обеспечить ушибленному органу покой

#375

При повреждении связок в рамках оказания первой помощи надо:

согреть поврежденный сустав, обеспечить покой

наложить повязку, фиксирующую сустав, прикладывать холодный компресс

интенсивно растереть, наложить тугую повязку

осторожно растереть травмированный участок

#376

При переломах конечностей у пострадавшего и отсутствия транспортных шин и подручных средств, для их изготовления можно:

верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу, а нижние конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань

верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу, а нижние конечности прибинтовывают друг к другу не выпрямляя, проложив между ними мягкую ткань

верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу, а нижние конечности выпрямляют и плотно прижимают друг к другу

верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу, а нижние конечности выпрямляют и плотно прижимают друг к другу

#377

Иммобилизация – это ...

запрещение передвижения в опасной зоне

обездвиживание пострадавшей части тела

перенесение пострадавшего в безопасное место

влияние излучения приборов на пострадавшего

#378

Перелом позвоночника фиксируют:

три шинами

укладывают пострадавшего на твердый щит

накладывают тугую бинтовую повязку

укладывают пострадавшего на бок

#379

При переломе костей таза проводят иммобилизацию путем:

наложения двух шин

укладывают больного на твердый щит

укладывают больного на твердый щит и под коленные суставы подкладывают упругий валик

наложения трех шин

#380

При вывихе плеча:

накладывают шину, не меняя положения плеча

вправляют вывих

прибинтовывают плечо к туловищу

прибинтовывают кисть к туловищу

#381

Тяжелую травму, как правило, сопровождает общая реакция организма

повышенная раздражительность

слабость

депрессия

апатия

шок

#382

При наложении шины в случае перелома кости бедра обездвиживают суставы:

голеностопный

тазобедренный

коленный

тазовокрестцовый

поясничной части позвоночника

#383

При оказании первой помощи пострадавшему с травмой конечности, в ране которого – торчащий обломок стекла, необходимо:

срочное извлечение обломка

принятие мер по обездвиживанию пораженной конечности

наложение повязки из чистой ткани поверх обломка

дать пострадавшему обезболивающее лекарство

наложение повязки из чистой ткани после извлечения обломка

смазывание краев раны жировым веществом

#384

Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания производится:

в положении на спине

в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку)

с приподнятыми нижними конечностями

в полусидячем положении

#385

Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших?

дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке он не впал в кому
проверить состояние пострадавшего, насколько он готов к транспортировке

оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию поврежденных частей тела, если они имеются

придать пострадавшему оптимальное положение

#386

Как оказать первую помощь при открытом переломе конечности?

туго перебинтовать поврежденную конечность

совместить костные отломки друг с другом, наложить повязку, зафиксировать конечность с помощью шины

наложить повязку на рану, зафиксировать конечность с помощью шины

наложить давящую повязку

#387

Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга?

похолодание тела, потеря сознания

головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания

деформация черепа, очковая гематома

тошнота, судороги

#388

Назовите симптомы вывиха:

боль в конечности, общая слабость

боль в конечности, деформация области сустава, отсутствие движения в суставе

резкая боль, отек, патологическая подвижность

общая слабость, боль

#389

В каких случаях пострадавшего извлекают из салона автомобиля?

всегда при потере потерпевшим сознания

при потере потерпевшим сознания и отсутствии у него пульса на сонной артерии и признаков дыхания

при переломах нижних конечностей

при артериальном кровотечении

#390

Каков порядок оказания помощи в случаях падения с высоты при сохранении сознания?

оценить состояние пострадавшего

переложить пострадавшего на ковшовые носилки

переложить пострадавшего на вакуумный матрас

зафиксировать пострадавшего на вакуумном матрасе в позе «лягушки»

посадить пострадавшего

#391

Действия в случае длительного сдавливания конечностей:

обложить конечности холодом

после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности

согреть придавленные конечности

не давать жидкости до прибытия врачей

#392

В каком состоянии пострадавших переносят только на животе:

в состоянии комы

при частой рвоте

в случаях ожога спины и ягодиц

при подозрении на повреждение спинного мозга, когда в наличии есть только

при проникающих ранениях брюшной полости

при проникающих ранениях грудной клетки

#393

Укажите, в каком положении госпитализируют пострадавших при успешной реанимации после утопления:

лежа на боку с опущенным подголовником носилок

лежа на боку с приподнятым подголовником носилок

лежа на спине на жестких (щитовых) носилках

положение пострадавшего на носилках не имеет значения

#394

Клинические признаки, встречающиеся при любом виде травм:

боль, деформация, патологическая подвижность

боль, гематома, отек

боль, гематома, ограничение движений

боль, гематома, патологическая подвижность

#395

Ушиб – это ...

механическое повреждение тканей без видимого нарушения их целостности

механическое повреждение тканей с видимым нарушением их целостности

любое механическое повреждение тканей

любое механическое или иное повреждение тканей

#396

В качестве первой помощи при ушибах чаще всего применяется:

холод к месту ушиба

тугие повязки на место ушиба

иммобилизация места ушиба

растирание обезболивающими мазями

#397

Вывих – это ...

стойкое смещение суставных концов сочленяющихся костей

нестойкое (легко устранимое) смещение суставных концов сочленяющихся костей

периодически возникающее смещение суставных концов сочленяющихся костей

нарушение целостности суставных концов сочленяющихся костей

#398

Укажите клинические признаки вывиха:

боль, гематома, отек

изменение конфигурации пораженного сустава

резкое ограничение или полное отсутствие движений в пораженном суставе

патологическая подвижность

#399

Перелом – это ...

полное нарушение целостности кости

частичное нарушение целостности кости

полное или частичное нарушение целостности кости

нарушение целостности кости с обязательным повреждением надкостницы

#400

Укажите признаки перелома:

боль, гематома, отек

деформация в области перелома

при повреждении конечности – нарушение функции конечности

при повреждении конечности – нарушение функции конечности только в случаях повреждения в области сустава

#401

Основной признак перелома – это ...

усиление боли при осевой нагрузке на сломанную кость

ослабление боли при осевой нагрузке на сломанную кость

крепитация костных отломков при движении

патологическая подвижность

#402

Выберите правильную последовательность действий при оказании доврачебной помощи пострадавшему при подозрении на перелом:

шинирование, холод на область перелома, обезболивание

обезболивание, холод на область перелома, шинирование

обезболивание, шинирование, холод на область перелома

холод на область перелома, шинирование, обезболивание

#403

Укажите правильную последовательность действий при оказании помощи пострадавшему с открытым переломом лучевой кости (повреждения лучевой артерии нет):

обезболивание, повязка на рану, шинирование, холод на область перелома, транспортировка в лечебное учреждение

шинирование, повязка на рану, холод на область перелома, обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение

повязка на рану, шинирование, холод на область перелома, обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение

холод на область перелома, повязка на рану, шинирование, обезболивание, транспортировка в лечебное учреждение

#404

Если при открытом переломе имеется повреждение артерии, то кровоостанавливающий жгут накладывается:

в первую очередь

после проведения обезболивания для избежания травматического шока

после применения холода для уменьшения кровопотери

в порядке, обусловленном силой кровотечения

#405

При подозрении на повреждение ключицы возможно проведение иммобилизации:

ватно-марлевыми кольцами Дельбе

повязкой типа Дезо

8-образной повязкой

шиной Еланского

#406

При наложении шины при повреждениях кисти необходимо:

положить валик под ладонь

плотно прификсировать ладонь к шине

противопоставить 1 палец, если он не поврежден

если 1 палец поврежден, то фиксировать его вместе со всей кистью

#407

Черепно-мозговая травма – это ...

механическое повреждение костей черепа и головного мозга

повреждение только головного мозга

механическое повреждение костей черепа

ранение мягких тканей черепа без повреждения костей

#408

Укажите основной признак черепно-мозговой травмы:

головные боли и головокружение

потеря больным сознания в момент травмы

тошнота, рвота после травмы

вялость, сонливость

#409

Синдром длительного сдавления развивается примерно через ...

40 минут непрерывного сдавления

не ранее чем, через 1,5-2 часа непрерывного сдавления

10-15 минут непрерывного сдавления

более чем, через 2 часа после непрерывного сдавления

#410

Углублению травматического шока способствует ...

кровопотеря

неправильная иммобилизация

травматичная транспортировка

обезболивание

#411

Оказание ПП при травматическом шоке на догоспитальном этапе складывается из основных пунктов:

при нарушениях дыхания и остановке сердца – сердечно-легочная реанимация

остановка наружного кровотечения

обезболивание, правильная иммобилизация

борьба с гиповолемией (введение полиглюкина, реополиглюкина и т.д.)

#412

Признаки травмы органов брюшной полости:

сильная боль, болезненность или чувство сдавленности в животе, появление синяков, рвота (иногда с кровью или черного цвета), слабость, кровь в кале (черный кал)

сильная боль, болезненность или чувство сдавленности в животе, появление синяков, рвота (иногда с кровью), слабость, кровь в кале (черный кал)

сильная боль, болезненность или чувство сдавленности в животе, появление синяков, рвота (черного цвета), слабость, кровь в кале (черный кал)

сильная боль, болезненность или чувство сдавленности в животе, появление синяков, рвота, слабость, кровь в кале

сильная боль, болезненность или чувство сдавленности в животе, появление синяков, рвота (иногда с кровью или черного цвета), слабость, кровь в кале (кал со слизью)

#413

Признаки закрытого повреждения живота, сопровождающееся внутрибрюшным кровотечением:

бледность, холодный пот, жалобы на головокружение, головокружение усиливается при вертикальном положении тела, пульс частый, одышка

бледность, холодный пот, жалобы на головокружение

жалобы на головокружение, головокружение усиливается при вертикальном положении тела

бледность, холодный пот, жалобы на головокружение, головокружение усиливается при вертикальном положении тела, пульс частый

бледность, холодный пот, жалобы на головокружение, головокружение усиливается при вертикальном положении тела, одышка

#414

Признаки закрытого повреждения живота, сопровождающегося разрывом полого органа:

бледность, выражение лица напряженное, живот напряжен, пульс частый, дыхание учащено

бледность, выражение лица напряженное, любое движение приводит к усилению болей, пульс частый, дыхание учащено

бледность, выражение лица напряженное, любое движение приводит к усилению болей, живот напряжен, пульс частый, дыхание учащено

бледность, выражение лица напряженное, любое движение приводит к усилению болей, живот напряжен, дыхание учащено

бледность, выражение лица напряженное, любое движение приводит к усилению болей, живот напряжен, пульс частый

#415

Первая помощь при травматическом шоке:

накрыть пострадавшего одеялом или пальто, попросить его занять положение лежа (голова на одном уровне с телом), поднять ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к жизненно важным органам (не поднимать ноги при травме головы, шеи, позвоночника, бедра или голени, подозрении на сердечный приступ, инсульт), не давать питье (можно смачивать губы водой, если он испытывает жажду)

накрыть пострадавшего одеялом или пальто, попросить его занять положение лежа (голова на одном уровне с телом), поднять ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к жизненно важным органам (не поднимать ноги при травме позвоночника, бедра или голени, подозрении на сердечный приступ, инсульт), не давать питье (можно смачивать губы водой, если он испытывает жажду)

накрыть пострадавшего одеялом или пальто, попросить его занять положение лежа (голова на одном уровне с телом), поднять ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к жизненно важным органам (не поднимать ноги при травме головы, шеи, позвоночника, бедра или голени, подозрении на сердечный приступ, инсульт), не давать питье

накрыть пострадавшего одеялом или пальто, попросить его занять положение лежа (голова на одном уровне с телом), поднять ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к жизненно важным органам (не поднимать ноги при травме головы, шеи, позвоночника, подозрении на сердечный приступ, инсульт), не давать питье (можно смачивать губы водой, если он испытывает жажду)

накрыть пострадавшего одеялом или пальто, попросить его занять положение лежа (голова на одном уровне с телом), поднять ноги на 30 см выше уровня тела, чтобы улучшить приток крови к жизненно важным органам (не поднимать ноги при травме головы, шеи, позвоночника, бедра или голени, подозрении на сердечный приступ), не давать питье (можно смачивать губы водой, если он испытывает жажду)

#416

Правила наложения шины:

накладывается без изменения положения поврежденной части, шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, расположенные выше и ниже этой области, до и после наложения шины проверить кровообращение в поврежденной части тела (спросить пострадавшего, немеют ли у него кончики пальцев поврежденной конечности, проверить пальцы поврежденной конечности (должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей), при жалобах на онемение ослабить повязку, зафиксировать шину выше и ниже области повреждения)

накладывается без изменения положения поврежденной части, шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, расположенные выше и ниже этой области, до и после наложения шины проверить кровообращение в поврежденной части тела(спросить пострадавшего, немеют ли у него кончики пальцев поврежденной конечности, проверить пальцы поврежденной конечности (должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей), при жалобах на онемение ослабить повязку, зафиксировать шину выше и ниже области повреждения

накладывается без изменения положения поврежденной части, шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, расположенные выше и ниже этой области, до и после наложения шины проверить кровообращение в поврежденной части тела(спросить пострадавшего, немеют ли у него кончики пальцев поврежденной конечности, проверить пальцы поврежденной конечности (должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей), при жалобах на онемение ослабить повязку, зафиксировать шину выше и ниже области повреждения

накладывается без изменения положения поврежденной части, шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, расположенные выше и ниже этой области, до и после наложения шины проверить кровообращение в поврежденной части тела(спросить пострадавшего, немеют ли у него кончики пальцев поврежденной конечности, проверить пальцы поврежденной конечности (должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей), при жалобах на онемение ослабить повязку, зафиксировать шину выше и ниже области повреждения

накладывается без изменения положения поврежденной части, шина должна охватывать как область повреждения, так и суставы, расположенные выше и ниже этой области, до и после наложения шины проверить кровообращение в поврежденной части тела(спросить пострадавшего, немеют ли у него кончики пальцев поврежденной конечности, проверить пальцы поврежденной конечности (должны быть теплые на ощупь и иметь розовый цвет у ногтей), при жалобах на онемение ослабить повязку, зафиксировать шину выше и ниже области повреждения

#417

Признаки закрытого перелома:

отсутствие раны в зоне перелома, нарушение прямолинейности

отсутствие раны в зоне перелома, нарушение прямолинейности и появление ступеньки в месте перелома, подвижность, боль, припухлость

отсутствие раны в зоне перелома, нарушение прямолинейности и появление ступеньки в месте перелома

отсутствие раны в зоне перелома, нарушение прямолинейности и появление ступеньки в месте перелома, подвижность

отсутствие раны в зоне перелома, нарушение прямолинейности и появление ступеньки в месте перелома, подвижность, боль

#418

Первая помощь при повреждении черепа, если пострадавший находится в бессознательном состоянии:

пострадавшего надо уложить на спину на носилки в положении полуоборота, под одну из сторон туловища подложить валик из верхней одежды, голову повернуть в левую сторону, чтобы в случае возникновения рвоты рвотные массы не попали в дыхательные пути, а вытекли наружу, расстегнуть стягивающую одежду, если у пострадавшего имеются зубные протезы и очки, то снять их, при острых нарушениях дыхания произвести искусственное дыхание

пострадавшего надо уложить на спину на носилки в положении полуоборота без подушки, под одну из сторон туловища подложить валик из верхней одежды, голову повернуть в левую сторону, чтобы в случае возникновения рвоты рвотные массы не попали в дыхательные пути, а вытекли наружу, расстегнуть стягивающую одежду, если у пострадавшего имеются зубные протезы и очки, то снять их, при острых нарушениях дыхания произвести искусственное дыхание

пострадавшего надо уложить на спину на носилки в положении полуоборота, под одну из сторон туловища подложить валик из верхней одежды, голову повернуть в правую сторону, чтобы в случае возникновения рвоты рвотные массы не попали в дыхательные пути, а вытекли наружу, расстегнуть стягивающую одежду, если у пострадавшего имеются зубные протезы и очки, то снять их, при острых нарушениях дыхания произвести искусственное дыхание

пострадавшего надо уложить на спину на носилки в положении полуоборота, под одну из сторон туловища подложить валик из верхней одежды, голову повернуть в левую сторону и подложить под нее подушку, расстегнуть стягивающую одежду, если у пострадавшего имеются зубные протезы и очки, то снять их, при острых нарушениях дыхания произвести искусственное дыхание

пострадавшего надо уложить на спину на носилки в положении полуоборота, под одну из сторон туловища подложить валик из верхней одежды, голову повернуть в левую сторону, чтобы в случае возникновения рвоты рвотные массы не попали в дыхательные пути, а вытекли наружу, расстегнуть стягивающую одежду, при острых нарушениях дыхания произвести искусственное дыхание

#419

Первая помощь при травматическом вывихе:

при вывихе в плечевом зафиксировать верхнюю конечность бинтом к туловищу при вывихе суставов нижней конечности зафиксировать бинтом поврежденную ногу к здоровой ноге или к подручным средствам, придав больному суставу неподвижность, применить холод

при вывихе локтевом суставе верхнюю конечность бинтом подвесить руку на косынке, при вывихе суставов нижней конечности зафиксировать бинтом поврежденную ногу к здоровой ноге или к подручным средствам, придав больному суставу неподвижность, применить холод

при вывихе в плечевом или локтевом суставе зафиксировать верхнюю конечность бинтом к туловищу или подвесить руку на косынке, при вывихе суставов нижней конечности зафиксировать

бинтом поврежденную ногу к здоровой ноге или к подручным средствам, придав больному суставу неподвижность, применить холод

при вывихе в плечевом или локтевом суставе зафиксировать верхнюю конечность бинтом к туловищу или подвесить руку на косынке, при вывихе суставов нижней конечности зафиксировать бинтом поврежденную ногу к здоровой ноге или к подручным средствам, применить холод

при вывихе в плечевом или локтевом суставе зафиксировать верхнюю конечность бинтом к туловищу или подвесить руку на косынке, при вывихе суставов нижней конечности зафиксировать бинтом поврежденную ногу к здоровой ноге или к подручным средствам, придав больному суставу неподвижность

#420

Первая помощь при закрытых повреждениях живота и его полости:

пострадавшего уложить на носилки на спину, при внутрибрюшном кровотечении дать холод на живот

пострадавшего уложить на носилки на левую сторону, при внутрибрюшном кровотечении дать холод на живот

пострадавшего уложить на носилки на правую сторону, при внутрибрюшном кровотечении дать холод на живот

пострадавшего уложить на носилки на живот при внутрибрюшном кровотечении дать холод на живот

#421

Переломы бывают:

позвоночника

ключицы и шейных позвонков

конечностей

открытые и закрытые

грудной клетки

#422

Первая помощь при повреждениях грудных и поясничных позвонков:

повернуть пострадавшего на спину, связать руки на груди за запястья, связать ноги в области коленных суставов и лодыжек, у головы пострадавшего установить носилки, на которые на уровне

поясницы положить валик из полотенца или одежды, обратив внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины, приподнять пострадавшего уложить его на носилки

повернуть пострадавшего на спину, связать ноги в области коленных суставов и лодыжек, у головы пострадавшего установить носилки, на которые на уровне поясницы положить валик из полотенца или одежды, обратив внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины, приподнять пострадавшего, передвинуть носилки под пострадавшего и опустить его на носилки

повернуть пострадавшего на спину, связать руки на груди за запястья, связать ноги в области коленных суставов и лодыжек, у головы пострадавшего установить носилки, на которые на уровне поясницы положить валик из полотенца или одежды, обратив внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины, приподнять пострадавшего, передвинуть носилки под пострадавшего и опустить его на носилки

повернуть пострадавшего на спину, связать руки на груди за запястья, у головы пострадавшего установить носилки, на которые на уровне поясницы положить валик из полотенца или одежды, обратив внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины, приподнять пострадавшего, передвинуть носилки под пострадавшего и опустить его на носилки

повернуть пострадавшего на спину, связать ноги в области коленных суставов и лодыжек, у головы пострадавшего установить носилки, на которые на уровне поясницы положить валик из полотенца или одежды, обратив внимание на то, чтобы не было прогиба в области спины, приподнять пострадавшего, передвинуть носилки под пострадавшего и опустить его на носилки

#423

Признаки перелома свода черепа:

гематома в области волосяного покрова части головы, рана при открытом повреждении, нарушение сознания и дыхания, другие изменения, выявленные при ощупывании

гематома в области волосяного покрова части головы

гематома в области волосяного покрова части головы, рана при открытом повреждении

гематома в области волосяного покрова части головы, рана при открытом повреждении, нарушение сознания

гематома в области волосяного покрова части головы, рана при открытом повреждении, нарушение сознания и дыхания

#424

Признаки травматического шока:

бледная, холодная и влажная кожа, слабость, беспокойство, сухость во рту, жажда

бледная, холодная и влажная кожа, слабость, беспокойство, сухость во рту, жажда, слабый учащенный пульс

бледная, холодная и влажная кожа, слабость, беспокойство, сухость во рту, жажда, слабый учащенный пульс, учащенное дыхание, бессознательное состояние

бледная, холодная и влажная кожа, слабость, беспокойство, сухость во рту, жажда, слабый учащенный пульс, учащенное дыхание, спутанность сознания, бессознательное состояние

бледная, холодная и влажная кожа, слабость, сухость во рту, жажда, слабый учащенный пульс, учащенное дыхание, спутанность сознания, бессознательное состояние

#425

Признаки перелома нижней челюсти:

жалобы на боль в месте повреждения, усиливающуюся при речи

жалобы на боль в месте повреждения, усиливающуюся при речи и открывании рта, невозможность сомкнуть зубы, возможна кратковременная потеря сознания

жалобы на боль в месте повреждения, усиливающуюся при речи и открывании рта, невозможность сомкнуть зубы

жалобы на боль в месте повреждения, усиливающуюся при речи и открывании рта, невозможность сомкнуть зубы, возможно впадение в кому

жалобы на боль, усиливающуюся при речи и открывании рта, невозможность сомкнуть зубы, возможна кратковременная потеря сознания

#426

Политравма — это:

Повреждение одного органа или одного сегмента конечности

Собирательное понятие: повреждение двух и более различных областей тела, органов, сегментов конечностей, вызванных воздействием двух и более поражающих факторов

Способ транспортировки пострадавшего

повреждение одного сегмента конечности

#427

Укажите простейшие приемы обезболивания при оказании первой помощи

«Холод» на область травмы

Иммобилизация

Физиологически выгодное(удобное) положение

Все перечисленное

#428

Укажите причины острой дыхательной недостаточности, возникающей при травме груди:

Травма ребер

Травма легкого

Ушиб сердца

Травма печени

#429

Укажите транспортное положение пострадавшего без сознания с травмой груди

Полусидя

Лежа на спине

Лежа на поврежденном боку

Сидя

#430

Укажите признаки травмы позвоночника с повреждением спинного мозга

Боль в области травмы

Снижение или отсутствие чувствительности в конечностях

Понижение температуры тела

Отсутствие движения (паралич) конечностей

#431

Укажите, в каких случаях пострадавшим в ДТП накладывается «шейный воротник» или «воротниковая шина», изготовленная из подручных материалов

Травма или подозрение на травму шейного отдела позвоночника

Всем пострадавшим в ДТП

Только при подозрении на черепно-мозговую травму

При повреждении сонной артерии

#432

Укажите признаки открытых переломов

Наличие раны в области травмы

Понижение температуры тела

Деформация конечности

Кровотечение в месте травмы

Наличие в ране костных отломков

#433

Укажите достоверный признак открытого перелома

Наличие раны в области травмы

Боль в области травмы

Наличие в ране костных отломков

Кровотечение в месте травмы

Отек в области травмы

#434

Термин «иммобилизация» означает:

Придание удобного положения поврежденной части тела пострадавшего

Создание неподвижности поврежденной части тела пострадавшего

Способ транспортировки пострадавшего

Наложение давящей повязки

#435

Для иммобилизации поврежденных конечностей используют шины, изготовленные из подручных материалов:

Доски

Картон

Металлические пруты

Лыжи

Поясной ремень

#436

**Укажите, в каком положении транспортируют пострадавшего с травмой грудной клетки.
Пострадавший в сознании**

Лежа на спине

В положении полусидя

Лежа на животе

На боку

#437

**Укажите, в каком положении транспортируют пострадавшего с травмой грудной клетки.
Пострадавший без сознания**

Лежа на спине

В положении полусидя

Лежа на животе

Лежа на боку

#438

Пострадавшего нельзя поить, если у него:

Подозрение на травму живота

Сдавливание нижних конечностей

Отсутствует сознание

Обширные ожоги

#439

Перечислите простейшие приемы обезболивания

Придание пострадавшему удобного положения

Иммобилизация поврежденного участка тела

«Холод» на область травмы

«Тепло» на область травмы

#440

Меры оказания первой помощи при закрытом переломе

наложение давящей повязки

иммобилизация, холод на место перелома

тугая циркулярная повязка

тепло на место перелома

#441

При оказании первой помощи при вывихе необходимо:

попытаться вправить вывих

дать обезболивающее

наложить тугую повязку на сустав

иммобилизовать конечность, приложить холод, вызвать скорую помощь

#442

При переломе плечевой кости производят иммобилизацию следующих суставов:

только места перелома

места перелома и лучезапястного сустава

лучезапястного, локтевого и плечевого суставов

места перелома, локтевого и плечевого суставов

#443

Положение, придаваемое пострадавшему с переломом костей черепа при транспортировке:

горизонтальное

горизонтальное, голова фиксирована и повёрнута в сторону

полусидячее

лёжа на щите

#444

Транспортировка пострадавшего с переломом костей таза осуществляется в положении:

лежа на боку

«лягушки», с валиком под коленными суставами

лежа на животе

на щите с валиком под шеей

#445

Транспортировка пострадавшего с переломом позвоночника осуществляется в положении:

лежа на боку

«лягушки», с валиком под коленными суставами

лежа на животе

лёжа на спине на щите

#446

Признаками перелома являются все перечисленные симптомы, кроме:

пружинистая фиксация, удлинение конечности

боль, кровоподтёки

крепитация

укорочение конечности

#447

При переломе голени необходимо обездвижить:

только места перелома

места перелома и коленного сустава

места перелома, коленный и голеностопный суставы

места перелома, тазобедренного, коленного и голеностопного суставов

#448

Признаками вывиха являются все перечисленные симптомы, кроме:

боль и деформация конечности

крепитация, патологическая подвижность в месте травмы

нефизиологическое положение конечности

пружинистая фиксация

#449

При переломе костей предплечья производится иммобилизация:

только места перелома

места перелома и лучезапястного сустава

места перелома, лучезапястный и локтевой суставы

места перелома, локтевого и плечевого суставов

#450

Меры оказания первой помощи при ушибе:

грелку на место ушиба

холод, тугая повязка, обезболивание

растирание места ушиба

согревающий компресс на место ушиба

#451

Признаки перелома ребер:

боль в грудной клетке в покое

боль в грудной клетке усиливается при кашле, чихании

боль в грудном отделе позвоночника

боль в грудной клетке при наклоне головы

#452

Первая помощь при открытом переломе, сопровождающемся повреждением артерии

наложить жгут, асептическая повязка

иммобилизация

наложить повязку, обезболивающее, транспортировка в лечебное учреждение

наложить жгут, асептическую повязку, иммобилизация, вызвать скорую помощь

#453

Первая помощь при синдроме длительного сдавливания:

наложить жгут, растирание

холод, обезболивающее

тугая повязка, холод, иммобилизация

обложить конечность грелками

#454

Признаки синдрома верхней полой вены (травматической асфиксии):

лицо и шея одутловаты, багрово-синюшного цвета

прогрессирующее снижение артериального давления

мелкоточечные кровоизлияния в области грудной клетки и шеи

кровотечение из носа и ушей

наличие раны грудной клетки

кровь в ране пузырится

непроизвольное мочеиспускание

#455

При поражении человека электрическим током в первую очередь необходимо:

проверить пульс на сонной артерии

проверить наличие дыхания

приступить к закрытому массажу сердца

приступить к проведению искусственных вдохов

прекратить воздействие электрического тока

#456

Первая помощь при отравлении угарным газом:

вынести пострадавшего на свежий воздух

обильное промывание желудка

выпить 0,5 стакана раствора активированного угля

принять сердечные препараты

освободить пострадавшего от стягивающей одежды

#457

Первая помощь при попадании инородных тел в дыхательные пути взрослого:

перегнуть через спинку кресла, скамейки или собственное бедро

ударить несколько раз раскрытой ладонью между лопатками

ударить несколько раз кулаком между лопатками

ударить несколько раз ребром ладони между лопатками

уложить пострадавшего на спину, запрокинуть голову и попытаться удалить инородное тело пинцетом или корнцангом

#458

Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых

удалить жало из раны

приложить холод к месту укуса

дать обильное и желательно сладкое питье

при потере сознания больного оставить лежа на спине

использовать грелку и согревающие компрессы

при потере сознания больного повернуть на живот

#459

Действия в случае отравления ядовитыми газами

вынести на свежий воздух, в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь

в случае потери сознания более 4 минут — повернуть на живот и приложить холод к голове

искусственное дыхание изо рта в рот проводить без использования специальных масок

вызвать рвоту

#460

Признаки бледного утопления

бледно серый цвет кожи

широкий нереагирующий на свет зрачок

отсутствие пульса на сонной артерии

часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта

набухание сосудов шеи

отсутствие пульса у лодыжек

#461

Признаки истинного утопления

кожа лица и шеи с синюшным отеком

набухание сосудов шеи

обильные пенистые выделения изо рта и носа

широкий нереагирующий на свет зрачок

отсутствие пульса на сонной артерии

часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта

#462

При признаках закупорки дыхательных путей умеренной степени следует выполнить следующие мероприятия первой помощи:

постучать основанием ладони в межлопаточную область пострадавшего для извлечения инородного тела

предложить пострадавшему откашляться

выполнить 5 резких толчков в подвздошную область живота пострадавшего

в этом случае мероприятия первой помощи не требуются

#463

Выберите основные признаки закупорки инородным телом верхних дыхательных путей тяжелой степени у пострадавшего:

не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое), хватается за горло, не может говорить, только кивает

хватается за горло, кашляет, просит о помощи

надрывно кашляет, пытается что-то сказать, лицо багровеет

жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях, говорит, что «поперхнулся», просит постучать по спине

#464

Пострадавший внезапно потерял сознание. Дыхание присутствует. Выберите необходимое действие:

следует уложить пострадавшего в устойчивое боковое положение (позу восстановления, стабильное боковое положение)

для профилактики возможного вдыхания рвотных масс необходимо уложить пострадавшего на живот

голову пострадавшего набок

для скорейшего восстановления сознания необходимо надавить пострадавшему на болевые точки (угол нижней челюсти, верхняя губа и т. д.)

следует дать понюхать нашатырный спирт на ватке

необходимо придать положение на спине с приподнятыми ногами для обеспечения лучшего кровоснабжения головного мозга пострадавшего

#465

При полной закупорке инородным телом верхних дыхательных путей оказание первой помощи следует начать с действия:

попытаться удалить инородное тело резким ударом в верхнюю часть живота

спросить пострадавшего: «Вы подавились? Разговаривать сможете?»

нанести несколько ударов в межлопаточную область, наклонив пациента вперед

вызвать скорую медицинскую помощь

попытаться вызвать рвоту у пациента, надавив двумя пальцами на корень языка

выяснить у пострадавшего, чем он подавился

#466

Беременная женщина подавилась, не может ни говорить, ни кашлять, хватается за горло. Какую первую помощь необходимо оказать?

5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 толчков в живот

5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 толчков в грудину

5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 5 вдохов

5 толчков в грудину, если инородное тело не вышло – 5 вдохов

#467

Первая помощь при утоплении, после извлечения пострадавшего из воды:

удалить воду из дыхательных путей, проверить дыхание, если его нет – провести сердечно-легочную реанимацию

проверить дыхание, если его нет – осуществить искусственное дыхание

проверить дыхание, если его нет – осуществить сердечно-легочную реанимацию

удалить воду из дыхательных путей, проверить дыхание, если его нет – осуществить искусственное дыхание

#468

Первая помощь при электротравме заключается в следующем:

прекратить действие тока, вызвать скорую медицинскую помощь, определить наличие признаков жизни

вызвать скорую медицинскую помощь, прекратить действие тока, следить за признаками жизни

прекратить действие тока, проверить признаки жизни, вызвать скорую медицинскую помощь

последовательность действий не имеет значения

#469

При подозрении на отравление пострадавшего ядовитым веществом, поступившим в его организм через желудочно-кишечный тракт, необходимо:

вызвать скорую медицинскую помощь

предложить пострадавшему вызвать рвоту (если он в сознании)

собрать образцы яда для анализа

дать пострадавшему попить воды

открыть окно, уложить и охладить голову

#470

Ваши действия при первой помощи подавившемуся пострадавшему, который находится в сознании, не может говорить, наблюдается кашель:

хлопать ладонью по спине пока не откашляется

выполнить два полных вдувания в легкие через рот

двумя пальцами надавить на корень языка пострадавшего

попытаться извлечь инородное тело пальцами или пинцетом

обхватить пострадавшего сзади и сложенными в замок кистями сильно надавить под диафрагму

#471

Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным газом?

уложить, согреть, напоить горячим напитком

вынести на чистый воздух, растереть тело, протереть виски нашатырным спиртом

перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область сердца с помощью холодных компрессов

открыть окно, уложить и охладить голову

#472

Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?

провести реанимационные мероприятия, срочно госпитализировать

закопать пострадавшего в землю

дать обезболивающее средство

провести ИВЛ

#473

Правила перемещения в зоне "шагового" напряжения:

передвигаться следует в диэлектрических ботах или галошах либо «гусиным шагом» – пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги. под шаговое напряжение можно попасть в радиусе 8 м от места касания электрического провода земли

передвигаемся бегом, отрываем подошвы от земли, широкими шагами

прикасаемся к пострадавшему без предварительного обесточивания

прикасаемся к металлическим предметам без предварительного обесточивания

#474

Каков порядок освобождения от действия электрического тока при напряжении выше 1000 В?

надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши

взять изолирующую штангу или изолирующие клещи

замкнуть провода вл 6-20 кв накоротко методом наброса, согласно специальной инструкции

сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего

оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 м от места касания провода земли или от оборудования, находящегося под напряжением

отбросить металлическим предметом без предварительного обесточивания

#475

Признаки бледного утопления:

бледно серый цвет кожи

широкий не реагирующий на свет зрачок

отсутствие пульса на сонной артерии

часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта

набухание сосудов шеи

отсутствие пульса у лодыжек

#476

Признаки истинного утопления:

кожа лица и шеи с синюшным отеком

набухание сосудов шеи

обильные пенистые выделения изо рта и носа

широкий не реагирующий на свет зрачок

отсутствие пульса на сонной артерии

часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта

#477

Действия в случае укуса змей и ядовитых насекомых:

удалить жало из раны

приложить холод к месту укуса

дать обильное и желательно сладкое питье

при потере сознания больного оставить лежа на спине

использовать грелку и согревающие компрессы

при потере сознания больного повернуть на живот

#478

Утопление – это один из видов ...

острой дыхательной недостаточности

острой сердечно-сосудистой недостаточности

хронической дыхательной недостаточности

нарушения деятельности центральной нервной системы

#479

Различают следующие типы утопления:

синкопальное

постепенное

истинное

асфиксическое

#480

Пути проникновения яда в организм:

с пищей, с водой

через дыхательные пути

через рану

с атмосферными осадками

#481

При попадании отравляющего вещества в дыхательные пути в первую очередь необходимо:

начать сердечно-легочную реанимацию

вынести или вывести пострадавшего на свежий воздух

начать искусственное дыхание

начать ингаляции кислорода, увлажненного спиртом

#482

Первая помощь при утоплении:

уложив пострадавшего животом на бедро, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на грудь, удалить воду из желудка и легких, далее приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

уложив пострадавшего животом на бедро, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, далее приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

уложив пострадавшего животом на бедро, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на спину, удалить воду из желудка и легких, далее приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

уложив пострадавшего животом на бедро, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, далее приступить к проведению искусственного дыхания

уложив пострадавшего животом на бедро, чтобы голова пострадавшего свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, далее приступить к непрямого массажа сердца

#483

Признаки утопления:

выделение пены изо рта, остановка дыхания и сердечной деятельности, посинение кожных покровов, расширение зрачков

выделение пены изо рта

выделение пены изо рта, остановка дыхания

выделение пены изо рта, остановка дыхания и сердечной деятельности, расширение зрачков

выделение пены изо рта, остановка дыхания и сердечной деятельности, посинение кожных покровов

#484

Первая помощь при электротравме:

немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем выключения рубильника, перерубания электропровода, при нарушении дыхания или внезапной остановки сердца, приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем выключения рубильника, перерубания электропровода, при нарушении дыхания или внезапной остановки сердца, приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем выключения рубильника, отброса или перерубания электропровода, при нарушении дыхания или внезапной остановки сердца, приступить к проведению искусственного дыхания

немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем выключения рубильника, отброса или перерубания электропровода, при нарушении дыхания или внезапной остановки сердца, приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

немедленно освободить пострадавшего от действия тока путем выключения рубильника, отброса или перерубания электропровода, при нарушении дыхания или внезапной остановки сердца, приступить к проведению непрямого массажа сердца

#485

Первая помощь при попадании кислоты на кожу

положить пузырь со льдом

дать рвотные средства

кожу сразу промыть под струей воды, можно использовать мыло или слабый раствор щелочи (2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода))

необходимо провести промывание желудка 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода) 2-3 л

#486

Первая помощь при отравлении щелочами «через рот»

рекомендуется принимать рвотные средства

рекомендуется принимать слабительное

дать теплое питье (чай, кофе)

необходимо срочно промыть желудок чистой кипяченной водой 2-3 л

#487

Первая помощь при отравлении, которое связано с употреблением грибов в пищу

необходимо вызвать рвоту и сделать промывание желудка (нужно выпить большое количество чистой воды 2-3 л. и раздражать корень языка пальцами, что приведет к рефлексорной рвоте)

принять пищу

пострадавшего уложить, согреть с помощью грелок

дать обильное питье (чай, вода)

#488

Первая помощь при отравлении недоброкачественной пищей

рекомендуется выпить теплое молоко

дать солевое слабительное

необходимо промыть желудок до чистых промывных вод, выпивают большое количество чистой воды до 2-3л. или 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода) 2-3 л

принять пищу

#489

Первая помощь при отравлении ядовитыми растениями

принять пищу

проведение дезинфекции в жилом помещении, где находится пострадавший

искусственная вентиляция легких

промыть желудок 0,1% раствором калия перманганата (слабо-розовый раствор марганца), или чистой водой до 2-3л

#490

Первая помощь при отравлении атропиносодержащими растениями (красавка, белена, дурман):

произвести промывание желудка чистой водой до чистых промывных вод до 2-3л

рекомендуется выпить теплое молоко

искусственная вентиляция легких

дать понюхать с ватки нашатырный спирт

#491

Первая помощь при ожогах:

холод, наложение стерильной повязки

смазывание обожжённой поверхности мазью

обработка обожжённой поверхности спиртом

обработка обожжённой поверхности перекисью водорода

#492

Первая помощь в случае алкогольного отравления в бессознательном состоянии

вызвать рвотный рефлекс

промыть желудок 2-3 л воды с добавлением пищевой соды (1ч.л. соды на 1л воды), т.е 2 % раствором гидрокарбоната натрия или чистой водой

уложить пострадавшего на живот, чтобы избежать попадания рвотных масс в дыхательные пути при рвоте, которая может возникнуть спонтанно

дать слабительное

#493

Первая помощь при отравлении раствором уксусной кислоты

промывание желудка холодной водой (2-3 л.)

дать слабительное и рвотные средства

дать активированный уголь

искусственная вентиляция легких

#494

Первая помощь при вдыхании паров уксусной кислоты

дать рвотные средства

промыть желудок 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода) или чистой водой

следует прополоскать горло и промыть нос 2% раствором гидрокарбоната натрия (пищевая сода)

рекомендуется выпить теплое молоко с содой или щелочную минеральную воду (Боржоми)

#495

Порядок действий при оказании помощи пораженному электрическим током:

Начать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца

Провести диагностирование, начать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание

Обесточить пострадавшего, провести диагностирование, при необходимости приступить к реанимационным мерам

Вызвать скорую помощь

#496

Местные признаки ожога I степени:

жжение, боль

пузыри со светлым содержимым

пузыри с тёмным содержимым

образование струпа

#497

Местные признаки ожога II степени:

жжение, боль

жжение, боль, пузыри со светлым содержимым

пузыри с тёмным содержимым

образование

#498

Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и влажностью возможен

солнечный удар

травматический шок

травматический токсикоз

тепловой

#499

У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (под-кожная клетчатка, мышцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, какая у него степень ожога

I

II

IIIa

IIIб

IV

#500

Укажите вещество, при отравлении которым кожные покровы пострадавшего становятся розовыми

Метиловый спирт

Снотворные вещества

Угарный газ

Хлор

Наркотические

#501

Укажите основные причины утопления

Попадание воды в легкие во время произвольных дыхательных движений под водой

Рефлекторная остановка сердца при внезапном попадании в холодную воду

Спазм голосовых связок при попадании на них воды

Паралич дыхательного центра головного мозга

#502

Пострадавший, спасенный после утопления, должен быть госпитализирован:

После состояния клинической смерти

После продолжительной потери сознания

После кратковременной потери сознания

Во всех случаях утопления

#503

Прием Геймлиха (прием удаления инородного тела из верхних дыхательных путей) у пострадавших с ожирением и у беременных женщин выполняют путем сжатия в области:

Верхней части грудины

Нижней части грудины

Верхней части живота

При боковом сдавливании грудной клетки

#504

Перечислите группы пострадавших, которым нельзя применять прием удаления инородного тела из верхних дыхательных путей при помощи сжатия брюшной полости

Беременные женщины

Тучные люди

Пожилые люди

Младенцы

Подростки

#505

В первом периоде переохлаждения (стадия компенсации) наблюдаются:

бледность кожи

покраснение кожи

мышечная дрожь

отсутствие мышечной дрожи

снижение температуры тела

температура тела практически не изменяется

сонливость

#506

Во втором периоде переохлаждения (стадия декомпенсации) наблюдаются:

сужение сосудов кожи

расширение сосудов кожи

сонливость

возбуждение

температура тела прогрессивно снижается

температура тела сохраняется в пределах 35°C

озноб

#507

Первая помощь при отморожении пальцев рук (ног):

энергично растереть кисти (стопы) снегом

провести энергичный массаж конечности (можно со спиртом)

дать обезболивающее

дать снотворное

сделать ванночку для кисти (стопы) с температурой воды 36°C

сделать ванночку для кисти (стопы) с температурой 22°C с постепенным ее повышением до 37-40°C

наложить асептическую повязку

#508

Признаки отморожения I степени:

побледнение кожи

покраснение кожи

потеря чувствительности поврежденного участка кожи

пузыри с прозрачным желеобразным содержимым

длительный период заживления с образованием рубцов

#509

Первая помощь при общем переохлаждении:

энергично растереть тело снегом

провести энергичное растирание (массаж) поверхности тела, можно водкой

накормить

поместить в ванну с температурой воды 36°C

поместить в ванну с температурой воды 20-22°C с постепенным ее повышением до 30°C

#510

Признаки переохлаждения

озноб и дрожь

нарушение сознания: заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение

посинение или побледнение губ

снижение температуры тела

потеря чувствительности

нет пульса у лодыжек

#511

Что делать, если ребенок получил ожог пламенем, кипятком или паром?

вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и одновременно с этим охлаждать место ожога холодной проточной водой не менее 20 минут

вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком и одновременно с этим приложить холодный предмет к месту ожога, предварительно обернув его куском ткани

вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать за ребенком

вызвать скорую медицинскую помощь, до ее приезда наблюдать и обработать спиртом

#512

Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?

Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать

Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить пострадавшего водой

Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить пострадавшего водой

накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать

#513

Признаки переохлаждения

нет пульса у лодыжек

посинение или побледнение губ

озноб и дрожь

нарушение сознания: заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение

снижение температуры тела

потеря чувствительности

#514

При глубоком ожоге необходимо оказать следующую первую помощь:

накрыть ожог влажной салфеткой, вызвать скорую медицинскую помощь, принять противошоковые меры

охладить место ожога, затем накрыть ожог влажной салфеткой

охладить место ожога, затем наложить влажную повязку, вызвать скорую медицинскую помощь

вызвать скорую медицинскую помощь, обработать пораженную область перекисью водорода

#515

В случае развития отморожения конечности наиболее важно:

укутать пострадавшего

наложить на конечность термоизолирующую повязку

как можно скорее поместить отмороженную конечность в теплую воду

растереть конечность шерстяной тканью

напоить пострадавшего теплым чаем

#516

Тепловой удар возникает при:

накоплении тепла в организме, в связи с длительным воздействием высокой температуры

длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову или обнаженное тело

накоплении тепла в организме, в связи с длительным воздействием низкой температуры

длительном воздействии высокой температуры на организм человека

#517

Солнечный удар возникает при:

накоплении тепла в организме, в связи с длительным воздействием высокой температуры

длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову или обнаженное тело

накоплении тепла в организме, в связи с длительным воздействием низкой температуры

длительном воздействии высокой температуры на организм человека

#518

В рамках первой помощи при ожогах необходимо:

доставить пострадавшего в ближайшее теплое помещение, наложить чистую влажную повязку, покой, противошоковые меры

убрать поражающий фактор, охладить место ожога, наложить чистую влажную повязку, покой, противошоковые меры, вызвать скорую помощь

срочно вызвать врача или скорую помощь, противошоковые меры, охладить место ожога

убрать поражающий фактор, место ожога освободить от одежды, наложить повязку, вызвать скорую помощь

#519

Укажите основное мероприятие первой помощи при ожоге:

охладить пораженный участок тела

приложить холод, усадить, наклонить голову вперед и вниз

остановить кровотечение

наложить давящую повязку

доставить в теплое место

наложить шину

#520

Какие меры по оказанию первой помощи пострадавшему необходимо предпринять в случае термических ожогов?

прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку

прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, обрезать одежду вокруг ожогов, наложить сухую стерильную повязку, дать обезболивающее, обильное питье

прекратить действие высокотемпературного поражающего фактора, снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку, дать обезболивающее

снять горящую одежду, смазать пузыри кремом или жиром и наложить сухую повязку

#521

В каком случае переохлаждение считается легким?

если температура тела человека не опустилась ниже 36°C

если температура тела человека не опустилась ниже 34°C

если температура тела человека не опустилась ниже 32°C

если температура тела человека не опустилась ниже 35°C

#522

Как оказать первую медицинскую помощь при термическом ожоге?

укутать конечность подручным материалом

наложить холодный компресс

наложить стерильную повязку

промыть холодной водой

#523

Как оказать первую медицинскую помощь при химическом ожоге?

обильно промыть холодной водой, наложить стерильную повязку

обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку

промыть перекисью водорода, наложить стерильную повязку

обработать перманганатом, наложить стерильную повязку

#524

Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)?

полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода, накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать. дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки

вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой

пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод и поить пострадавшего водой

дать болеутоляющее средство из индивидуальной аптечки

#525

Признаки переохлаждения:

озноб и дрожь

нарушение сознания: заторможенность и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение

посинение или побледнение губ

снижение температуры тела

потеря чувствительности

нет пульса у лодыжек

#526

Укажите признаки термических ожогов 1 степени:

гиперемия обожженного участка, чувство боли и жжения

гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные пузыри

кожа бледная, беспокоит чувство боли или жжения

гиперемия обожженного участка, чувствительность резко снижена, боли нет

#527

Укажите признаки термических ожогов 2 степени:

гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются прозрачные пузыри

гиперемия обожженного участка, на фоне которой определяются геморрагические пузыри и обрывки вскрывшихся пузырей

кожа пораженного участка багрово-синюшная, определяются прозрачные пузыри

имеется сухая раневая поверхность, окруженная струпом

#528

Укажите признаки термических ожогов 4 степени:

темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг темная, просвечивают тромбированные подкожные вены, сильная боль

темно-коричневый плотный струп, кожа вокруг струпа практически не изменена, боль умеренная

кожа темная, до черного цвета, мумификация пораженного участка, чувствительности в пораженном участке нет

беловатый, рыхлый струп, кожа вокруг струпа гиперемирована, боль умеренная

#529

Первая помощь при тепловом ударе:

пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца

пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца

пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца

пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, напоить холодной водой, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца

пострадавшего срочно вынести в прохладное место, освободить от одежды, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца

#530

Первая помощь при обморожениях:

пострадавшего внести в теплое помещение, снять обувь и перчатки, обмороженную конечность вначале растереть сухой тканью, затем поместить в таз с теплой 30...32,5°C водой и в течение 10 мин температуру воды довести до 41,5°C, вытереть насухо обмороженную конечность и протереть 33% раствором спирта, наложить асептическую или чистую повязку (можно надеть чистые проглаженные носки или перчатки), при общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем

пострадавшего внести в теплое помещение, снять обувь и перчатки, обмороженную конечность вначале растереть сухой тканью, затем поместить в таз с теплой 32...34,5°C водой и в течение 10 мин температуру воды довести до 40,5°C, вытереть насухо обмороженную конечность и протереть 33% раствором спирта, наложить асептическую или чистую повязку (можно надеть чистые проглаженные носки или перчатки), при общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем

пострадавшего внести в теплое помещение, снять обувь и перчатки, обмороженную конечность вначале растереть сухой тканью, затем поместить в таз с теплой 31...33,5°C водой и в течение 10 мин температуру воды довести до 42,5°C, вытереть насухо обмороженную конечность и протереть 33% раствором спирта, наложить асептическую или чистую повязку (можно надеть чистые проглаженные носки или перчатки), при общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем

пострадавшего внести в теплое помещение, снять обувь и перчатки, обмороженную конечность вначале растереть сухой тканью, затем поместить в таз с теплой 32...34,5°C водой и в течение 10 мин температуру воды довести до 43,5°C, вытереть насухо обмороженную конечность и протереть 33% раствором спирта, наложить асептическую или чистую повязку (можно надеть чистые

проглаженные носки или перчатки), при общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем

пострадавшего внести в теплое помещение, снять обувь и перчатки, обмороженную конечность вначале растереть сухой тканью, затем поместить в таз с теплой 32,5...35,0°C водой и в течение 10 мин температуру воды довести до 40,5°C, вытереть насухо обмороженную конечность и протереть 33% раствором спирта, наложить асептическую или чистую повязку (можно надеть чистые проглаженные носки или перчатки), при общем охлаждении пострадавшего необходимо тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем

#531

Первая помощь при солнечном ударе:

перенести пострадавшего в прохладное помещение, снять с него одежду, положить холод на голову и в область сердца, дать обильное солевое питье, при тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

перенести пострадавшего в прохладное помещение или в тень, снять с него одежду, положить холод на голову и в область сердца, дать обильное солевое питье, при тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

перенести пострадавшего в тень, снять с него одежду, положить холод на голову и в область сердца, дать обильное солевое питье, при тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

перенести пострадавшего в прохладное помещение или в тень, снять с него одежду, положить холод на голову и в область сердца, при тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

перенести пострадавшего в прохладное помещение или в тень, положить холод на голову и в область сердца, дать обильное солевое питье, при тяжелых формах приступить к проведению искусственного дыхания и непрямого массажа сердца

#532

Первая помощь при термических ожогах:

кожу обильно промыть проточной водой, при попадании в глаз химического вещества промыть его в течение 10 минут, завязать поврежденный глаз

немедленно удалить одежду, пропитанную химикатом, кожу обильно промыть теплой водой, при попадании в глаз химического вещества промыть его в течение 15 минут, завязать поврежденный глаз

немедленно удалить одежду, пропитанную химикатом, кожу обильно промыть проточной водой, при попадании в глаз химического вещества промыть его в течение 20 минут

немедленно удалить одежду, пропитанную химикатом, кожу обильно промыть проточной водой, при попадании в глаз химического вещества промыть его в течение 30 минут, завязать поврежденный глаз

немедленно удалить одежду, пропитанную химикатом, кожу обильно промыть проточной водой, при попадании в глаз химического вещества промыть его в течение 20 минут, завязать поврежденный глаз

#533

Первая помощь при термических ожогах:

немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 5...8 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем

немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 10...15 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем

немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 10...12 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем

немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 8...10 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем

немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 15...20 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем

#534

Степеней ожогов:

2

4

3

5

#535

Первая помощь при отравлении химическими веществами:

немедленно удалить слизь изо рта пострадавшего, наклонив на чайную ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта, если возникли признаки удушья провести искусственное дыхание, дать выпить 2...3 стакана воды, лучше со льдом, пострадавшего в бессознательном состоянии уложить без подушки на живот, голову повернуть в сторону, при западении языка, а также при судорогах осторожно запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх

немедленно удалить слюну изо рта пострадавшего, наклонив на чайную ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта, если возникли признаки удушья провести искусственное дыхание, дать выпить 2...3 стакана воды, лучше со льдом, пострадавшего в бессознательном состоянии уложить без подушки на живот, голову повернуть в сторону, при западении языка, а также при судорогах осторожно запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх

немедленно удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего, наклонив на чайную ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта, если возникли признаки удушья провести искусственное дыхание, дать выпить 2...3 стакана воды, лучше со льдом, пострадавшего в бессознательном состоянии уложить без подушки на живот, голову повернуть в сторону, при западении языка, а также при судорогах осторожно запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх

немедленно удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего, наклонив на чайную ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта, если возникли признаки удушья провести искусственное дыхание, дать выпить 2...3 стакана воды, лучше со льдом, пострадавшего в бессознательном состоянии уложить без подушки на живот, при западении языка, а также при судорогах осторожно запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх

немедленно удалить слюну и слизь изо рта пострадавшего, наклонив на чайную ложку кусок марли, платок или салфетку, протереть полость рта, если возникли признаки удушья провести искусственное дыхание, дать выпить 2...3 стакана воды, пострадавшего в бессознательном состоянии уложить без подушки на живот, голову повернуть в сторону, при западении языка, а также при судорогах осторожно запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть вперед и вверх

#536

Признаки обморожения:

кожа на пораженных участках холодная бледно-синюшного цвета, чувствительность отсутствует, вялость, безучастность, пульс редкий, температура тела меньше 36°C

кожа на пораженных участках холодная бледно-синюшного цвета, чувствительность отсутствует, вялость, безучастность, пульс редкий, температура тела меньше 36,5°C

кожа на пораженных участках холодная бледно-синюшного цвета, чувствительность отсутствует, вялость, безучастность, пульс редкий, температура тела меньше 36,1°C

кожа на пораженных участках холодная бледно-синюшного цвета, чувствительность отсутствует, вялость, безучастность, пульс редкий, температура тела меньше 35,5°C

кожа на пораженных участках холодная бледно-синюшного цвета, чувствительность отсутствует, вялость, безучастность, пульс редкий, температура тела меньше 36,9°C

#537

Признаки теплового удара:

общая слабость, разбитость, головная, боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда

общая слабость, разбитость, головная, боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота

общая слабость, разбитость, головная, боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота, покраснение кожных покровов

общая слабость, разбитость, головная, боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота, покраснение кожных покровов, пульс и дыхание учащены, температура повышена, потеря сознания в тяжелых случаях, иногда возникают судороги

общая слабость, разбитость, головная, боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота, покраснение кожных покровов, пульс и дыхание учащены

#538

Признаки солнечного удара:

тошнота, рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, в ряде случаев отмечаются бессознательное состояние, остановка дыхания и сердечной деятельности, обширные ожоги от солнечных лучей первой степени, могут возникать боли в затылочной области

тошнота, рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, в ряде случаев отмечаются бессознательное состояние

тошнота, рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, в ряде случаев отмечаются бессознательное состояние, остановка дыхания и сердечной деятельности

тошнота, рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, в ряде случаев отмечаются бессознательное состояние, остановка дыхания и сердечной деятельности, обширные ожоги от солнечных лучей первой степени

тошнота, рвота, кровотечение из носа, возможно расстройство зрения, учащаются пульс и дыхание, остановка дыхания и сердечной деятельности, обширные ожоги от солнечных лучей первой степени, могут возникать боли в затылочной области

#539

Первая помощь при термических ожогах:

немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 5...8 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем

немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 10...15 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем

немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 10...12 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем

немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 8...10 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем

немедленно начать охлаждение места ожога водопроводной водой в течение 15...20 минут, после этого на область ожога наложить чистую, лучше стерильную повязку, напоить пострадавшего горячим чаем

#540

Первая помощь при тепловом ударе:

пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца

пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца

пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца

пострадавшего срочно вынести в прохладное место, обеспечить доступ свежего воздуха, освободить от одежды, напоить холодной водой, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца

пострадавшего срочно вынести в прохладное место, освободить от одежды, напоить холодной водой, наложить холодный компресс на голову, при нарушениях сердечной и дыхательной деятельности приступить к выполнению искусственного дыхания и непрямому массажу сердца

#541

Причины потери сознания:

черепно-мозговая травма

отравление алкоголем

капиллярное кровотечение

инородное тело носа

острый гастрит

#542

Причины потери сознания:

растяжение связок

обморок

капиллярное кровотечение

остановка сердечной деятельности

колит

#543

Продолжительность обморока составляет ____ минут:

1–5

5–10

10–15

15–20

25–30

#544

Симптомы обморока:

повышение артериального давления

снижение артериального давления

побледнение кожных покровов

покраснение лица

цианоз носогубного треугольника

#545

Первая помощь при обмороке:

больного уложить

приподнять голову

приподнять ноги

дать понюхать флакон с нашатырным спиртом

дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом

поставить горчичник на затылочную область

поставить горчичник на икроножные мышцы

#546

Возникновению гипертонического криза способствуют:

психическое перенапряжение, стресс

длительное нахождение в душном помещении

внезапное прекращение приема средств, понижающих давление

переохлаждение

резкая перемена погоды

заболевания уха, горла и носа

заболевания легких

#547

Жалобы больного при гипертоническом кризе на:

кашель

головную боль с преимущественной локализацией в затылочной области

головокружение

боли в правом подреберье

тошноту, рвоту

боли в грудной клетке, усиливающиеся на вдохе

локальную боль в области грудной клетки

#548

Первая помощь при гипертоническом кризе:

голову опустить

голову приподнять

на голову холодный компресс

горчичники на затылочную область или икроножные мышцы

под язык – таблетку нитроглицерина

#549

Симптомы гипертонического криза:

пульс слабого наполнения

пульс напряжен

артериальное давление понижено

артериальное давление повышено

покраснение лица

побледнение лица

цианоз носогубного треугольника

#550

Причины инфаркта миокарда:

хронический гастрит

атеросклероз

нарушение свертываемости крови с формированием тромба

ослабление иммунозащитных сил организма

нервно-психическое перенапряжение

#551

Факторы риска инфаркта миокарда:

нервно-психическое перенапряжение, стресс

нахождение в душном помещении

переохлаждение

пожилой возраст

ожирение

#552

Развитие инфаркта миокарда связано с:

наличием врожденного или приобретенного порока сердца

повышением артериального давления

нарушением кровообращения в сосудах сердца

нарушением кровообращения в сосудах мозга

сужением почечной артерии

#553

Характеристика боли при инфаркте миокарда:

раздирающая боль за грудиной

боль в грудной клетке при кашле

боль отдает в левую половину тела (плечо, лопатку)

колющая боль в области сердца

резкая боль в правом или левом боку

#554

Первая помощь при инфаркте миокарда:

срочно вызвать врача скорой помощи

нитроглицерин под язык каждые 15 минут

горчичники на затылочную область

аспирин под язык

сделать закрытый массаж сердца

провести искусственное дыхание

горчичники на область сердца

#555

Инсульт – это:

нарушение мозгового кровообращения

нарушение кровообращения в сосудах сердца

кратковременная потеря сознания

резкое повышение артериального давления

приступ удушья

#556

Ишемический инсульт возникает в результате:

спазма артерий сердца

спазма артерий мозга

разрыва артерии мозга

тромбоза или эмболии артерии мозга

тромбоза или эмболии артерии сердца

#557

Геморрагический инсульт возникает в результате:

спазма артерий сердца

спазма артерий мозга

разрыва артерии мозга

тромбоза или эмболии артерии мозга

тромбоза или эмболии артерии сердца

#558

Предвестники инсульта:

синдром «перемежающейся» хромоты

преходящее онемение конечности

головокружение

преходящее расстройство сознания

резкие боли в области сердца

обморок

кашель

#559

Первая помощь при инсульте:

больного уложить, голову приподнять

больного уложить, ноги приподнять

нитроглицерин под язык каждые 15 минут

срочно вызвать врача

горчичники на затылочную область

#560

Боль при мигрени локализуется преимущественно в ... области:

височной

лобной

затылочной

теменной

в одной (правой или левой) половине головы

#561

Симптомы мигрени:

сдавливающая головная боль (симптом «каска»)

головокружение

слезотечение из одного глаза

снижение зрения

улучшение зрения

появление симптома «куриной слепоты»

боли в области сердца

#562

Симптомы острой пневмонии:

повышение температуры

приступы удушья

боли в грудной клетке при дыхании, кашле

боли в правой или левой половине живота

боли жгучего характера за грудиной

#563

Основным симптомом бронхиальной астмы является:

кашель

кровохарканье

повышенная потливость

боль в грудной клетке

приступ удушья

#564

При приступе бронхиальной астмы:

затруднен вдох

затруднен выдох

частота дыхания увеличивается

редкое дыхание

кровохарканье

боли в грудной клетке

свистящие хрипы при дыхании слышны на расстоянии

#565

Причины развития «острого живота»:

непроходимость кишечника

разрыв кисты яичника

острый гастрит

колит

дисбактериоз кишечника

#566

Причины развития «острого» живота:

острый гастрит

колит

тупая травма живота с разрывом внутренних органов

прободная язва желудка

дисбактериоз кишечника

#567

При наличии симптомов «острого» живота разрешено:

кормить, поить

делать очистительную клизму

давать обезболивающее

холод на живот

тепло на живот

#568

Симптомы «острого» живота:

понижение температуры тела

доскообразный живот

положительный симптом раздражения брюшины

непроизвольная дефекация

усиленное слюноотделение

#569

Анафилактический шок является тяжелой формой:

инсульта

инфаркта миокарда

бронхиальной астмы

пневмонии

аллергии

#570

Первая помощь при развитии аллергии на внутримышечное введение лекарственного препарата:

отсосать лекарство из ранки места инъекции

дать противоаллергическое средство

холод на место инъекции

тепло на место инъекции

горчичники на место инъекции

в ранку от инъекции закапать 5–6 капель санорина или галазолина

растереть место инъекции

#571

При приеме каустической соды и нашатырного спирта внутрь срочно необходимо:

выпить 0,5 стакана 2%-ного раствора пищевой соды

принять активированный уголь

принять рвотное средство

принять сердечные препараты

промыть желудок через толстый резиновый зонд

#572

При приеме уксусной кислоты внутрь срочно необходимо:

выпить 0,5 стакана 2%-ного раствора пищевой соды

принять активированный уголь

принять рвотное средство

принять обезболивающие препараты

промыть желудок через толстый резиновый зонд

#573

Признаки комы

потеря сознания более чем на 6 минут

потеря сознания более чем на 4 минуты

обязательно есть пульс на сонной артерии

нет пульса на сонной артерии

#574

Признаки обморока

кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин)

потеря сознания более 6 мин

потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

потеря чувствительности

#575

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на бок и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

2 минут

3 минут

4 минут

5 минут

6 минут

#576

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)

повернуть пострадавшего на бок, приложить к голове холод

повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову холод

освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову холод

освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову холод

#577

Какие основные признаки обморока

Потеря сознания не более 10 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

Потеря сознания не более 3-4 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

Потеря сознания не более 4-5 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

Потеря сознания не более 5-6 минут. Предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

#578

Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи?

На спину с вытянутыми ногами

Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушья в результате западания языка, его следует положить на живот, чтобы вызвать рвотный рефлекс

Чтобы пострадавший не мог погибнуть от удушья в результате западания языка, его следует положить на бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой

На спину с подложенным под голову валиком

#579

Признаки обморока

потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

кратковременная потеря сознания (не более 3-4 мин)

потеря чувствительности

потеря сознания более 6 мин

#580

Во время оказания первой помощи пострадавший внезапно побледнел, перестал реагировать на окружающее. Укажите, с чего вы начнете оказывать первую помощь:

проверите признаки дыхания

откроете дыхательные пути

позовете помощника

начнете компрессию грудной клетки

осмотрите пострадавшего

сделаете 2 вдоха искусственной вентиляции легких

проверите признаки сознания (потрясите пострадавшего и спросите: «Что с Вами?»)

#581

Пострадавшему с признаками травмы живота и таза рекомендуется придать следующее положение:

положение на спине с приподнятыми ногами

устойчиво боковое положение

сидячее положение

положение на спине с полусогнутыми и разведенными ногами

положение на животе

#582

Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, первое, что необходимо сделать, это:

осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний

позвать помощника

вызвать экстренные службы

осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и пострадавшего

#583

При обмороке в рамках первой помощи следует:

положить пострадавшего горизонтально и поднять ноги

обеспечить приток свежего воздуха

привести пострадавшего в сознание, похлопав его по щекам

дать пострадавшему понюхать нашатырный спирт

положить пострадавшего на бок и поднять ноги выше головы

вызвать скорую помощь, если пострадавший не приходит в сознании в течение 5-7 мин

#584

Чем состояние комы отличается от обморочного состояния?

потеря сознания более чем на 2 минуты

потеря сознания более чем на 5 минуты

ничем не отличается

при обмороке - не более 1 минуты

#585

Как оказать первую помощь при обмороке?

уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, протереть лицо холодной водой

перенести в прохладное место, уложить

уложить, согреть, напоить горячим напитком

охлаждать голову и область сердца, напоить холодным напитком

#586

Какие основные признаки обморока?

потеря сознания не более 1-2 минут, предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

потеря сознания не более 2-3 минут, предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

потеря сознания не более 3-4 минут, предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

потеря сознания не более 4-5 минут, предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

потеря сознания не более 5-6 минут, предшествует резкая слабость, головокружение, звон в ушах и потемнение в глазах

#587

Приоритетная цель помощи при обмороке

восстановление сознания

нормализация пульса

повышение артериального давления

уменьшение одышки

#588

«Острый живот» – это ...

симптом патологии органов брюшной полости

синдром, характеризующийся болями в животе и симптомами раздражения брюшины

диагностическое понятие при патологии органов брюшной полости

диагностическое понятие, заменяющее диагноз

#589

Клинические формы ишемических заболеваний сердца:

приступ стенокардии

инфаркт миокарда

коллапс

тромбоэмболия легочной артерии

#590

Стенокардические боли носят характер ...

колющих

сжимающих, давящих за грудиной

постоянных ноющих в левой половине грудной клетки

интенсивных болей за грудиной, более 20 минут, не купирующихся приемом нитроглицерина

#591

Укажите характерные симптомы инфаркта миокарда:

постоянные ноющие боли за грудиной

сжимающие боли за грудиной

падение АД

резкая головная боль

#592

Обмороку может предшествовать:

период дурноты

потемнение в глазах или мелькание «мушек»

онемение конечностей

потеря сознания

#593

Длительность обморока –

несколько минут

несколько часов

несколько секунд

до суток

#594

Анафилактический шок – это общая системная реакция, развитие которой ...

не зависит от путей введения антигена

напрямую связано с путем введения антигена

зависит от дозы аллергена

не зависит от дозы аллергена

#595

Гипертензивный криз характеризуется:

резким спазмом кровеносных сосудов

резким расслаблением кровеносных сосудов

преимущественным поражением сосудов головного мозга

преимущественным поражением коронарных сосудов

#596

Эпилептический припадок начинается с ...

клонических судорог

тонических судорог

гиперкинезов

локализованных судорог

#597

При эпилептическом припадке в момент судорог:

не следует жестко удерживать больного

следует жестко фиксировать больного к опоре, на которой он лежит

следует удерживать больного так, чтобы предотвратить травму головы

следует удерживать больного так, чтобы предотвратить травму конечностей

#598

Основной задачей оказания помощи пострадавшему с эпилептическим припадком является ...

предотвращение травмы головы

введение противосудорожных препаратов

предотвращение травмы опорно-двигательного аппарата

прерывание развивающегося припадка

#599

К предобморочным симптомам относятся:

обострение слуха и зрения

гиперемия лица

бледность кожи

слабость, тошнота

#600

Клинические признаки обморока:

внезапность развития

лихорадка

кратковременность и обратимость

развивается постепенно

#601

Первая помощь при обмороке:

пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха

пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом

пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом, обрызгать лицо холодной водой, согреть ноги или растереть их

пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом, обрызгать лицо холодной водой

пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом, согреть ноги или растереть их

#602

Первая помощь при коллапсе:

пострадавшего уложить на спину, нижнюю часть туловища и ноги несколько приподнять, дать понюхать нашатырный спирт, при сохраненном сознании дать пострадавшему крепкий горячий чай, к конечностям приложить грелки

пострадавшего уложить на спину без подушки, дать понюхать нашатырный спирт, при сохраненном сознании дать пострадавшему крепкий горячий чай, к конечностям приложить грелки

пострадавшего уложить на спину без подушки, нижнюю часть туловища и ноги несколько приподнять, дать понюхать нашатырный спирт, при сохраненном сознании дать пострадавшему крепкий горячий чай

пострадавшего уложить на спину без подушки, нижнюю часть туловища и ноги несколько приподнять, дать понюхать нашатырный спирт, при сохраненном сознании дать пострадавшему, если он в сознании, крепкий горячий чай, к конечностям приложить грелки

пострадавшего уложить на спину без подушки, нижнюю часть туловища и ноги несколько приподнять, при сохраненном сознании дать пострадавшему крепкий горячий чай, к конечностям приложить грелки

#603

Первая помощь при коме:

освободить дыхательные пути от слизи

освободить дыхательные пути от слизи, рвотных масс

освободить дыхательные пути от слизи, рвотных масс, инородных тел, провести искусственное дыхание методами «рот в рот»

освободить дыхательные пути от слизи, рвотных масс, инородных тел, провести искусственное дыхание методами «рот в нос»

освободить дыхательные пути от слизи, рвотных масс, инородных тел, провести искусственное дыхание методами «рот в рот», «рот в нос»

#604

Признаки коллапса:

бледность кожи, покрытой липким холодным потом, мраморно-синий цвет конечностей спадение вен и их неразличимость под кожей, западение глаз и заострение черт лица

бледность кожи, покрытой липким холодным потом, мраморно-синий цвет конечностей спадение вен и их неразличимость под кожей, западение глаз и заострение черт лица, резко падение артериального давления. с. бледность кожи, покрытой липким холодным потом, мраморно-синий цвет конечностей спадение вен и их неразличимость под кожей, западение глаз и заострение черт лица, резко падение артериального давления, отсутствие пульса или он едва прощупывается

бледность кожи, покрытой липким холодным потом, мраморно-синий цвет конечностей спадение вен и их неразличимость под кожей, западение глаз и заострение черт лица, резко падение

артериального давления, отсутствие пульса или он едва прощупывается, учащенное, поверхностное, иногда прерывистое дыхание

бледность кожи, покрытой липким холодным потом, мраморно-синий цвет конечностей спадение вен и их неразличимость под кожей, западение глаз и заострение черт лица, резко падение артериального давления, отсутствие пульса или он едва прощупывается, учащенное дыхание

#605

Первая помощь при отравлении сильнодействующими ядами:

срочно вызвать рвоту, предварительно дать пострадавшему выпить 1...2 стакана теплой воды, повторить эту процедуру 5...6 раз, после чего дать выпить 3...4 таблетки активированного угля, затем дать выпить слабительное, при возбуждении пострадавшего положить на голову холодный компресс и постараться удержать его в постели, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых сердечбиений и пульса

срочно вызвать рвоту, после чего дать выпить 3 таблетки активированного угля, затем дать выпить слабительное, при возбуждении пострадавшего положить на голову холодный компресс и постараться удержать его в постели, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых сердечбиений и пульса. с. срочно вызвать рвоту, предварительно дать пострадавшему выпить 4 стакана теплой воды, после чего дать выпить 3 таблетки активированного угля, затем дать выпить слабительное, при возбуждении пострадавшего положить на голову холодный компресс и постараться удержать его в постели, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до полного восстановления сердечной деятельности

срочно вызвать рвоту, предварительно дать пострадавшему выпить 3 стакана теплой воды, повторить эту процедуру 7 раз, после чего дать выпить 3...4 таблетки активированного угля, затем дать выпить слабительное, при возбуждении пострадавшего положить на голову холодный компресс и постараться удержать его в постели, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых сердечбиений и пульса

срочно вызвать рвоту, предварительно дать пострадавшему выпить 2 стакана теплой воды, повторить эту процедуру 5 раз, после чего дать выпить 4 таблетки активированного угля, затем дать выпить слабительное, при возбуждении пострадавшего положить на голову холодный компресс и постараться удержать его в постели, при необходимости провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до полного восстановления сердечной деятельности, появления отчетливых сердечбиений

#606

Признаки комы:

бледность лица, медленный пульс

бледность лица, медленный пульс, рвота, нарушение или отсутствие дыхания, непроизвольное мочеиспускание

бледность лица, медленный пульс, рвота

бледность лица, медленный пульс, рвота, нарушение дыхания

бледность лица, медленный пульс, рвота, отсутствие дыхания

#607

Признаки комы:

бледность лица, медленный пульс

бледность лица, медленный пульс, рвота, нарушение или отсутствие дыхания, непроизвольное мочеиспускание

бледность лица, медленный пульс, рвота

бледность лица, медленный пульс, рвота, нарушение дыхания

бледность лица, медленный пульс, рвота, отсутствие дыхания

#608

Некроз (омертвление) участка миокарда имеет место при:

инфаркте миокарда

стенокардии

кардиомиопатии

миокардите

#609

Первая медицинская помощь при истерическом припадке:

Попытаться уговорить больного

удалить посторонних, отвлечь пациента (уронить рядом что-либо, сбрызнуть лицо водой)

Подложить под голову одежду

После припадка обязательно сопроводить домой или в лечебное учреждение

#610

Меры оказания первой медицинской помощи при приступе стенокардии:

анальгин внутрь

нитроглицерин под язык

холод на область сердца

но-шпа внутрь

#611

Учащенное сердцебиение это:

тахикардия

брадикардия

аритмия

фибрилляция

#612

Урежение ритма сердца это:

тахикардия

брадикардия

аритмия

фибрилляция

#613

Повышение кровяного давления это:

атония

тахикардия

гипотония

гипертония

#614

Понижение кровяного давления это:

атония

тахикардия

гипотония

гипертония

#615

Тяжелая степень острой сосудистой недостаточности:

коллапс

обморок

сердечная астма

аритмия

#616

При эпилептическом припадке необходимо:

удерживать больного, прижав к полу, между зубов вставить ложку

уложить и дать успокаивающее средство

недопустить получение травмы, между зубов положить кусок ткани, при западении языка – повернуть набок больного

перенести больного в спокойное место, удалить посторонних, ожидать окончания припадка

#617

Симптомы стенокардии:

боли за грудиной, давящего характера, появляющиеся при физической и эмоциональной нагрузке, непродолжительные

боли в области сердца интенсивного, сжимающего, давящего характера, продолжительные

боли за грудиной во время глотания, кратковременное

боли за грудиной длятся от 30 мин до нескольких часов, связаны с поражением позвоночника

#618

Симптомы бронхиальной астмы:

удушье, кашель с пенистой мокротой

резкие боли за грудиной, чувство нехватки воздуха

удушье с затруднением выдоха, свистящие хрипы слышны на расстоянии

резко выраженные головные боли, тошнота, рвота

#619

Симптомы гипертонического криза:

резкое повышение АД, тошнота, сильная головная боль

бледные кожные покровы, покрытые липким холодным потом

удушье, кашель с выделением пенистой мокроты

тошнота, рвота, снижение артериального давления

#620

Гипертонический криз – это осложнение:

гипертонической болезни

стенокардии

инфаркта миокарда

коллапса

#621

При потере пострадавшим сознания и наличии пульса на сонной артерии для оказания первой помощи его необходимо уложить:

На спину с подложенным под голову валиком

На спину с вытянутыми ногами

На бок так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой

На живот

#622

При потере сознания и понижении артериального давления без кровотечения необходимо:

Положить пострадавшего так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать обезболивающее

Положить пострадавшего так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать успокоительное

Положить пострадавшего так, чтобы его ноги были выше уровня головы

Положить пострадавшего так, чтобы его голова была выше уровня ног

#623

Действия в случае обморока (кратковременной потери сознания) пострадавшего?

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть по-ясной ремень. Приподнять ноги. Надавить на болевую точку под носом

Приложить грелку к животу или пояснице. Надавить на болевую точку

Ничего не предпринимать, вызвать врача

Напоить чаем и накормить

Убедиться в наличии пульса. Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень. Приподнять ноги. Надавить на болевую точку. Вызвать врача

#624

При тепловом ударе необходим:

пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной голо-вой, положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное питьё

уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой голо-вой

уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой голо-вой

уложить пострадавшего в постель, дать кофе

#625

При недостатке кислорода все живые ткани постепенно погибают. Особенно чувствителен к недостатку кислорода головной мозг. Через сколько минут без кислорода клетки мозга начинают необратимо погибать:

через 10-12 минут

через 8-10 минут

через 5-7 минут

через 3-4 минуты

#626

Одной из основных причин инсульта может быть гипертоническая болезнь. Что это за болезнь?

разрыв патологически измененного кровеносного сосуда головного мозга

это понижение артериального давления крови

заболевание, характеризующееся повышением артериального давления крови

пониженный уровень кислорода в крови человека

#627

Внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его частей из-за острого нарушения кровообращения или кровоизлияния — это:

инфаркт

инсульт

острая сердечная недостаточность

судорога мозга

#628

Какова последовательность оказания первой помощи при коллапсе:

пострадавшего уложить на живот, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги несколько опустить, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги

пострадавшего уложить на спину, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего приподнять как можно выше, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, приложить лед к ногам

пострадавшего уложить на спину, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего несколько приподнять, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги

пострадавшего уложить на живот, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего несколько приподнять, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги

#629

Первая помощь при обмороке:

положить на бок, расстегнуть воротник, обеспечив приток свежего воздуха, дать пострадавшему нашатырный спирт, дать горячего сладкого чая

уложить пострадавшего на пол, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха, дать нашатырь, при отсутствии дыхания провести комплекс мероприятий по искусственному дыханию

уложить на спину с откинутой головой назад, расстегнуть воротник, поднести к носу вату с нашатырным спиртом, обрызгать холодной водой лицо, согреть ноги

пострадавшего уложить на живот, поднести к носу вату с нашатырным спиртом, обрызгать холодной водой лицо, согреть ноги

#630

Внезапно возникающая потеря сознания - это:

Шок

Обморок

Мигрень

Коллапс